بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ندا کلینک

ذہنی صحت اور نشے کے علاج کا جامع رہنما

خاندانوں اور پیشہ ور افراد کے لیے

A Complete Guide to Mental Health and Addiction Treatment

For Families and Professionals

ڈاکٹر بلال وڑائچ اور ہماری ماہرین کی ٹیم

Dr Bilal Warraich and Our Experts Team

ڈاکٹرز — کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹس — کلینیکل سائیکالوجسٹس

1999ء سے خدمت میں

99 ویسٹ ووڈ کالونی، لاہور، پاکستان

موبائل / واٹس ایپ: 0321-7507866

nidaclinic.com

تمہید

Disclaimer - How to Use This Booklet

ڈسکلیمر — یہ کتابچہ کیسے پڑھیں

Important Note

اہم نوٹ

یہ کتابچہ صرف عمومی تعلیم اور آگاہی کے لیے ہے۔ یہ کسی فرد کے ذاتی مرض کی تشخیص، علاج یا دوا کا مشورہ نہیں ہے۔ ہر مریض کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی دوا، ٹیسٹ یا علاج کا آغاز صرف اہل ڈاکٹر، ماہر امراض نفسیات یا ماہر نفسیات کے مشورے سے کریں۔

ندا کلینک کی یہ مطبوعہ ذہنی صحت اور نشے کے علاج کے بارے میں خاندانوں، مریضوں اور پیشہ ورانہ افراد کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں دی گئی معلومات مستند عالمی ذرائع — پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن (PHC) کے معیارات، امریکی ادارے NIDA اور SAMHSA کی تحقیق، WHO کی رہنمائی اور Hazelden Betty Ford Foundation کے تجربات — پر مبنی ہیں، تاہم یہ کسی طبی مشورے کا بدل نہیں۔

اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز خطرے میں ہے، خود کو نقصان پہنچانے کے خیالات ہیں، یا نشے کی زیادہ مقدار (overdose) کا شبہ ہے تو فوراً قریبی ہسپتال کی ایمرجنسی جائیں یا ندا کلینک سے رابطہ کریں: 0321-7507866۔

Remember

یاد رکھیں

نشے کی لت اور ذہنی امراض دماغ کی بیماریاں ہیں، کردار کی کمزوری نہیں۔ ان کا علاج ممکن ہے اور لاکھوں لوگ علاج کے بعد مکمل اور بامقصد زندگی گزار رہے ہیں۔

دیباچہ
Preface - Our Mission and Policies

دیباچہ — ہمارا مشن اور ہماری پالیسیاں



ندا کلینک 1999 سے لاہور، پاکستان میں ذہنی صحت اور نشے کے علاج کی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ڈاکٹر بلال اصغر وڑائچ اور ان کی ماہرین کی ٹیم — ڈاکٹرز، کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹ اور کلینیکل سائیکالوجسٹس — نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور ہر مشکل کے باوجود اسے آج تک آگے بڑھایا۔

ہمارا مشن سادہ اور واضح ہے: ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں؛ ان کی ذہنی صحت اور خوشی ہمارا مشن ہے۔ یہ ادارہ ہمارے لیے صرف کاروبار نہیں، پاکستانی معاشرے کے حق میں ہماری خدمت اور اپنی زمین کے کئے کچھ واپس ادا کرنے کی کوشش ہے۔

Our Mission

ہمارا مشن

- ہر مریض کو عزت، رازداری اور بے لاگ محبت کے ساتھ اعلیٰ معیار کا، ثبوت پر مبنی علاج فراہم کرنا۔
- نشے کے عادی افراد کو مکمل بحالی کے راستے تک پہنچانا — صرف نشہ چھڑانا نہیں، زندگی دوبارہ بنانا۔

- خاندانوں کو تعلیم اور سہارا دینا، کیونکہ بحالی گھر سے شروع ہوتی ہے۔
- معاشرے میں ذہنی امراض سے جڑی بدنامی کم کرنا، تاکہ ہر ضرورت مند بلا جھجک علاج کرا سکے۔

Our Policies - In the Light of PHC Standards

ہماری پالیسیاں — PHC معیارات کی روشنی میں

ندا کلینک پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے جاری کردہ کم از کم معیاراتِ خدمات (MSDS – Minimum Service Delivery Standards، دستاویز نمبر CG-19MS-ED1-270522) کے مطابق اپنا نظام چلاتا اور باقاعدہ جائزہ لیتا ہے۔ ان معیارات کی رو سے ہماری بنیادی پالیسیوں کا خلاصہ یہ ہے:

- قانونی حیثیت اور شفافیت: کلینک PHC سے رجسٹرڈ ہے؛ نام اور لائسنس نمبر صاف نمایاں ہے (ROM-1)۔
- عملے کی شناخت اور اہلیت: ہر ملازم کا شناختی کارڈ، تحریری ملازمت کا معاہدہ اور تصدیق شدہ اسناد (ROM-2، HRM-5)۔
- مریض کی رازداری اور پرائیویسی: معائنہ اور کاؤنسلنگ مکمل پرائیویسی کے ساتھ؛ مریض کی شناخت میڈیا یا کسی غیر متعلقہ شخص پر ظاہر نہ ہو (PRE-5)۔
- باخبر رضامندی: علاج شروع کرنے سے پہلے مریض اور خاندان کو مکمل معلومات اور لاگت کی وضاحت (PRE-2، PRE-3)۔
- شکایات کا ازالہ: شکایت باکس، شکایت رجسٹر اور منصفانہ، بروقت کارروائی (PRE-4)۔
- مسلسل بہتری: معیارِ خدمات کی مسلسل جانچ کے لیے CQI کمیٹی اور سینٹینل واقعات کا تجزیہ (CQI-1 تا CQI-3)۔
- حفاظت اور انفیکشن کنٹرول: آگ اور دیگر ہنگامی منصوبے، سالانہ مشقیں اور تحریری انفیکشن کنٹرول پروگرام (FMS-3، IPC-1)۔
- مکمل طبی ریکارڈ: ہر مریض کا الگ شناختی نمبر، تاریخ و دستخط کے ساتھ ریکارڈ (IMS-1)۔

ان پالیسیوں کی تفصیل اس کتابچے کے باب 18 اور 19 میں دی گئی ہے۔ ہم ان معیارات کو صرف کاغذی تقاضا نہیں سمجھتے؛ یہ ہمارے روزمرہ کام کا حصہ ہیں۔

تعارف

Nida Clinic - Serving Since 1999

ندا کلینک — 1999 سے خدمت کا سفر



1999 میں ندا کلینک کا آغاز چند بستروں اور ایک عزم کے ساتھ ہوا: پاکستان میں نشے کے علاج اور ذہنی صحت کی وہ سہولت فراہم کرنا جو بین الاقوامی معیار کے مطابق ہو۔ اس وقت معاشرے میں نشے کے مریض کو شرم سمجھا جاتا تھا اور ذہنی بیماری کا علاج آخری ترجیح تھا۔

ڈاکٹر بلال اصغر وڑائچ اور ان کی ٹیم نے محدود وسائل، مالی مشکلات اور سماجی رکاوٹوں کے باوجود اس ادارے کو قدم قدم آگے بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے آج ندا کلینک لاہور میں ذہنی صحت اور لت کے علاج کا ایک قابل اعتماد نام ہے، جہاں ہر سال سینکڑوں خاندان اپنے عزیزوں کی بحالی کے لیے آتے ہیں۔

1999 سے ندا کلینک — خدمت کا سفر



اللہ کے فضل سے، مشکلات کے باوجود، پاکستان کے لوگوں کی ذہنی صحت کے لیے وقف۔

ندا کلینک کے سفر کے اہم سنگِ میل

Our Team

ہماری ٹیم

ندا کلینک میں خدمات ایک مکمل کثیر الشعبہ ٹیم دیتی ہے: کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹ (ماہرین امراض نفسیات)، میڈیکل آفیسرز، کلینیکل سائیکالوجسٹس، تربیت یافتہ کاؤنسلرز، نرسنگ عملہ اور معاون عملہ۔ ہر رکن کی اہلیت PHC اور متعلقہ کونسلوں کے معیارات کے مطابق تصدیق شدہ ہے۔

Our Services

ہماری خدمات

- بڑے ذہنی امراض کی تشخیص اور علاج: ڈپریشن، اضطراب، بائی پولر، اسکیزوفرینیا اور دیگر۔
- نشے کی لت کا مکمل علاج: ڈی ٹاکس، رہائشی بحالی، بیرونی مریض (OPD) پروگرام اور بعد از علاج نگہداشت۔
- بارہ اقدامات اور منی سوٹا ماڈل پر مبنی علاجی پروگرام۔
- تمام مریضوں کے لیے نفسیاتی ٹیسٹنگ، بشمول نشے کے مریضوں میں شخصی عوارض کی شناخت۔
- خاندانی کاؤنسلنگ اور فیملی تھراپی۔
- خواتین اور نوجوانوں کے لیے خصوصی توجہ کے ساتھ پروگرام۔

Our Pledge

ہمارا عہد

ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی ذہنی صحت اور خوشی ہمارا مشن ہے۔ یہ کتابچہ اسی مشن کی ایک کڑی ہے — معلومات ہر اس گھر تک پہنچے جہاں کسی عزیز کو ہماری ضرورت ہے۔

فہرستِ مضامین
Table of Contents

تمہید — ڈسکلیمر — یہ کتابچہ کیسے پڑھیں 2

دیباچہ — دیباچہ — ہمارا مشن اور ہماری پالیسیاں 3

تعارف — ندا کلینک — 1999 سے خدمت کا سفر 5

باب 1 — ذہنی صحت اور ذہنی امراض — بنیادی باتیں 9

باب 2 — موڈ کے عوارض — ڈپریشن اور بائی پولر 11

باب 3 — اضطراب کے عوارض 13

باب 4 — ذہنی پریشانی اور دیگر امراض 15

باب 5 — نفسیاتی جانچ — ہر مریض کے لیے دستیاب 17

باب 6 — ثبوت پر مبنی علاج — ادویات اور نفسیاتی علاج 19

باب 7 — لت کیا ہے؟ — ایک بیماری، کمزوری نہیں 21

باب 8 — پاکستان اور دنیا میں نشے کی صورتحال 23

باب 9 — نشہ آور اشیاء — محرک ادویات (Stimulants) 25

باب 10 — نشہ آور اشیاء — افیونی ادویات (Opioids) 28

باب 11 — نشہ آور اشیاء — مسکن و خواب آور ادویات (Depressants) 30

باب 12 — بھنگ خاندان، ہیلیوسینوجن اور دیگر اشیاء 32

باب 13 — وٹھ ڈرال اور ڈی ٹاکس — پہلا قدم 34

باب 14 — ثبوت پر مبنی علاج کے طریقے 36

باب 15 — منی سوٹا ماڈل اور ہیزلڈن — ندا کلینک کا طریقۂ علاج 38

باب 16 — بارہ اقدامات — بحالی کا نقشہ 40

باب 17 — ندا کلینک کا علاجی پروگرام — قدم بہ قدم 43

باب 18 — خاندان کا کردار — بحالی کا پہلا محافظ 46

باب 19 — پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور MSDS معیارات 48

باب 20 — ندا کلینک میں PHC معیارات کا اطلاق 51

باب 21 — قابلِ اعتماد بین الاقوامی وسائل (انٹرنیٹ) 54

الف — اکثر پوچھے گئے سوالات (خاندانوں کے لیے) 56

ب — کلیدی اصطلاحات کی فرہنگ 58

ج — حوالہ جات 59

اختتام — آخری بات 60

باب 1

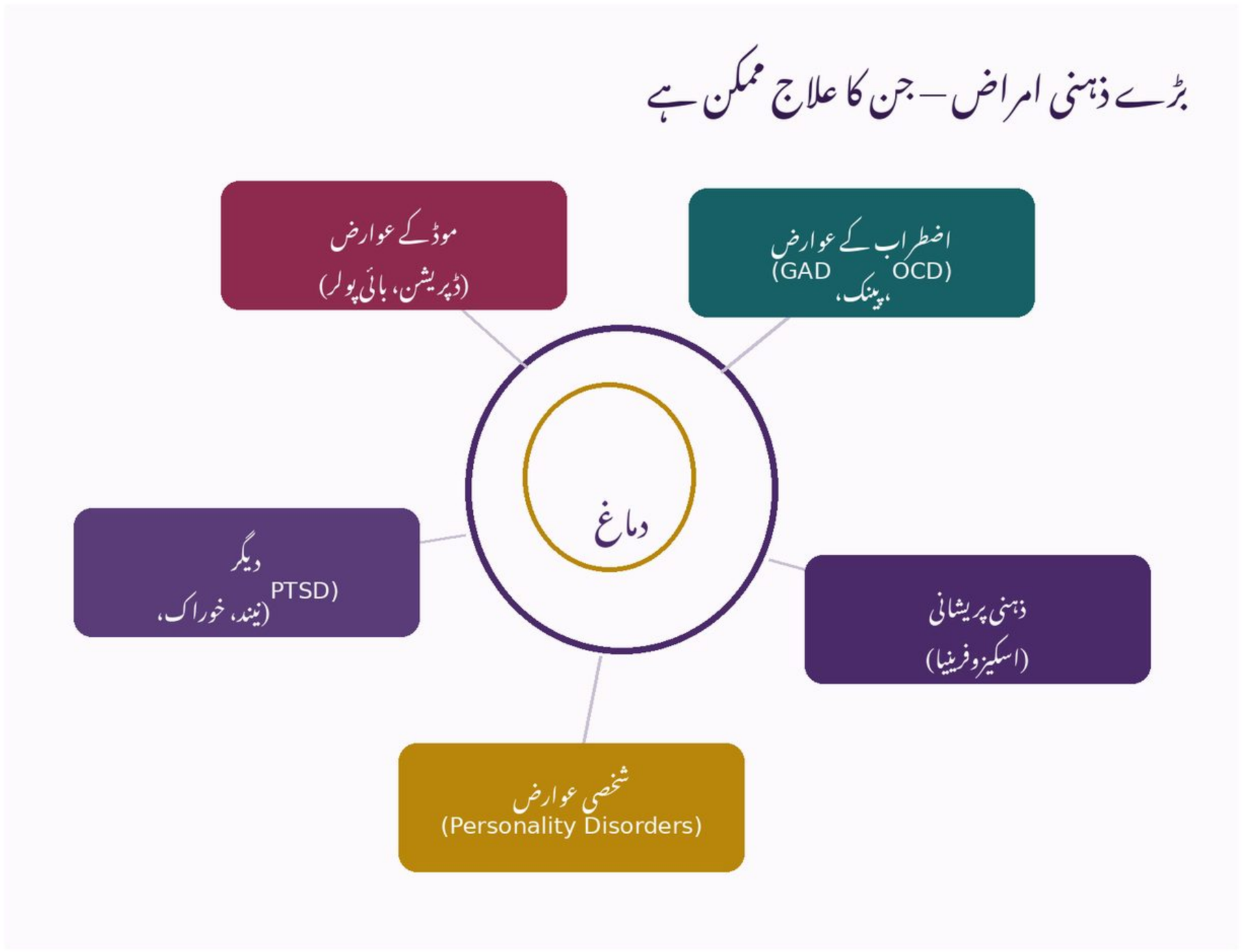
Mental Health and Mental Illness - The Basics

ذہنی صحت اور ذہنی امراض — بنیادی باتیں



ذہنی صحت کا مطلب صرف بیماری کی عدم موجودگی نہیں؛ یہ سوچنے، محسوس کرنے، تعلقات بنانے اور زندگی کے دباؤ سے نمٹنے کی وہ صلاحیت ہے جس سے انسان اپنا اور دوسروں کا حق ادا کر سکتا ہے۔ جیسے جسم کو بخار یا شوگر ہو سکتی ہے، ویسے ہی دماغ اور ذہن کو بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں — اور جیسے شوگر کا علاج ہوتا ہے، ویسے ہی ذہنی امراض کا بھی علاج ممکن ہے۔

بد قسمتی سے ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماری کو کمزوری، کردار کا عیب یا روحانی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس بدنامی کی وجہ سے لاکھوں لوگ برسوں تک خاموش تکلیف سہتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ذہنی امراض عام ہیں، ان کی وجوہات حیاتیاتی (دماغ کی کیمیا)، نفسیاتی (صدمات، دباؤ) اور سماجی (حالات، رشتے) ہوتی ہیں، اور بروقت علاج سے زیادہ تر مریض بہتر ہو سکتے ہیں۔



بڑے ذہنی امراض کے خاندان — ہر ایک کا علاج ممکن ہے

When to See a Specialist

کب ماہر سے رجوع کریں؟

- مسلسل دو ہفتے سے زیادہ اداسی، بے چینی یا بے نینی جو روزمرہ کام متاثر کرے۔
- نیند یا بھوک میں نمایاں تبدیلی، تھکاوٹ یا سوچوں میں بٹنا۔
- ایسی آوازیں سننا یا ایسے خیالات دیکھنا جو دوسروں کو نہیں ہوتے۔
- غصے کے اچانک ادوار یا موڈ کی انتہائی تبدیلیاں۔
- نشے کی عادت جو قابو سے باہر ہو۔
- خود کو یا کسی اور کو نقصان پہنچانے کے خیالات — یہ ایمرجنسی ہے؛ فوراً مدد لیں۔

For the Family

خاندان کے لیے

کسی عزیز میں یہ علامات نظر آئیں تو ڈرانے، شرمانے یا صرف حوصلہ دلانے کے بجائے مکمل توجہ سے سنیں اور ماہر سے ملاقات میں ساتھ جائیں۔ آپ کا ساتھ علاج کا آدھا حصہ ہے۔

باب 2

Mood Disorders - Depression and Bipolar Disorder

موڈ کے عوارض — ڈپریشن اور بائی پولر



Depression

ڈپریشن (اداسی کا عارضہ)

ڈپریشن عام اداسی نہیں بلکہ ایک حقیقی بیماری ہے جس میں کم از کم دو ہفتے تک گہری اداسی، دلچسپی کا خاتمہ، توانائی کی کمی، نیند اور بھوک کی خرابی، احساسِ کمتری اور مرتکز ہونے میں دشواری رہتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ معذوری پیدا کرنے والی بیماریوں میں ہے اور پاکستان میں بھی لاکھوں افراد متاثر ہیں۔

- علامات: مسلسل اداسی یا چڑچڑاپن، پہلے پسندیدہ کاموں سے بے دلی، تھکاوٹ، نیند میں کمی یا زیادتی، بھوک کا بڑھنا یا گھٹنا، احساسِ جرم، موت کے خیالات۔
- وجوہات: دماغ کے کیمیکل توازن (serotonin، norepinephrine)، وراثت، صدمے، مسلسل دباؤ، جسمانی بیماریاں اور بعض ادویات۔
- علاج: نفسیاتی علاج (خاص طور پر CBT) اور ضرورت کے مطابق anti-depressant ادویات — دونوں کا امتزاج سب

سے مؤثر ہے۔ زیادہ تر مریض ہفتوں میں نمایاں بہتری محسوس کرتے ہیں۔

Bipolar Disorder

بائی پولر ڈس آرڈر (دو قطبی عارضہ)

اس مرض میں موڈ کے دو مخالف ادوار آتے ہیں: کبھی مینیا (mania) — غیر معمولی خوشی یا چڑچڑاپن، بے اختیار تیز گفتگو، نیند کی نہایت کمی، بڑے بڑے غیر حقیقی منصوبے اور جوکھم بھرے فیصلے — اور کبھی گہری ڈپریشن۔ یہ ادوار صحت، ملازمت اور رشتوں کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔

- علامات مینیا کے: کم نیند کے باوجود بھرپور توانائی، مغرورانہ خیالات، فضول خرچی، بے قابو بولی، غصے کے اچانک دھماکے۔
- علاجmood stabilizer : ادویات ماہر امراض نفسیات کی نگرانی میں، ساتھ نفسیاتی علاج اور روزمرہ کے نظم (باقاعدہ نیند) کی تربیت۔ یہ ایک عمر کا ساتھ مانگنے والا مرض ہے، مگر مسلسل علاج سے مریض مکمل معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں۔

Warning

انتباہ

خودکشی کے خیالات کسی بھی ذہنی مریض میں سنگین علامت ہیں۔ ایسے خیالات ظاہر ہوں تو انہیں ہلکا نہ لیں، تنہا نہ چھوڑیں اور فوراً ماہر سے رابطہ کریں۔

باب 3
Anxiety Disorders

اضطراب کے عوارض



فکر کرنا انسانی فطرت ہے، مگر جب خوف اور بے چینی بے جا بڑھ جائے، مسلسل رہے اور زندگی کے راستے میں دیوار بن جائے تو یہ اضطراب کا عارضہ بن جاتا ہے۔ اضطراب کے عوارض دنیا میں سب سے عام ذہنی امراض ہیں اور ان کا علاج انتہائی کامیاب ہے۔

Generalized Anxiety Disorder (GAD)

عام اضطراب (GAD)

ہر معاملے میں مسلسل اور بے قابو فکر — صحت، پیسہ، بچے، مستقبل — جس کے ساتھ پٹھوں میں کھچاؤ، بے قراری اور نیند کی خرابی ہو۔

Panic Disorder

پینک ڈس آرڈر

اچانک خوف کے شدید حملے: دل کی دھڑکن بڑھنا، سانس کا پھولنا، چکر، پسینہ اور جیسے موت آگئی کا احساس — جو چند منٹ میں

عروج پر پہنچ کر گزر جاتا ہے۔ حملوں کے خوف سے مریض بازار، سفر یا بھیڑ سے گریز کرنے لگتا ہے۔

Phobias and Social Anxiety

فوبیا اور سماجی اضطراب

کسی خاص چیز (ایڑی، بلندی، کیڑے، تاریکی) یا سماجی صورتحال (سامنے بولنا، دعوتیں) سے غیر فطری خوف جس سے گریز کی عادت بن جائے۔

Obsessive-Compulsive Disorder (OCD)

وسواس (OCD)

ناپسندیدہ بار بار آنے والے خیالات (وسوسے) اور ان خیالات کو دبانے کے لیے بار بار کے عمل (دھونا، گننا، چیک کرنا)۔ مریض کو علم ہوتا ہے کہ یہ بے بنیاد ہے مگر قابو نہیں ہوتا۔

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

صدمے کے بعد کا اضطراب (PTSD)

کسی شدید صدمے (حادثہ، تشدد، قدرتی آفت) کے بعد بار بار یاد آنے والے منظر، بورے خواب، چوکنا رہنا اور جذباتی سنی۔

Treatment

علاج

اضطراب کے تمام عوارض میں نفسیاتی علاج — خاص طور پر CBT اور exposure therapy — پہلی لائن ہے؛ ضرورت پر ماہر امراض نفسیات ادویات بھی تجویز کر سکتے ہیں۔ نیند کا نظم، ورزش اور سانس کی مشقیں مددگار ہیں۔

باب 4

Psychosis and Other Conditions

ذہنی پریشانی اور دیگر امراض



Schizophrenia

اسکیزوفرینیا (ذہنی پریشانی)

اسکیزوفرینیا ایک سنگین مگر علاج پذیر دماغی بیماری ہے جس میں مریض کی سوچ، ادراک اور سلوک حقیقت سے ہٹ سکتے ہیں۔ اسے پاگلپن کہنا غلط اور ظالمانہ ہے — یہ بیماری ہے اور اس کا علاج موجود ہے۔

- مثبت علامات: وہم (بے بنیاد پختہ خیالات، مثلاً لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں) اور ہیلوسینیشن (ایسی آوازیں سننا جو کوئی اور نہیں سنتا)۔
- منفی علامات: جذبات کی کمی، بولی میں کمی، خود کی دیکھ بھال میں کوتاہی، سماجی علیحدگی۔
- علاج anti-psychotic : ادویات ماہر امراض نفسیات کی مسلسل نگرانی میں، خاندانی تعلیم اور سماجی بحالی۔ بروقت اور مسلسل علاج سے بہت سے مریض بہتر ہو کر کام اور گھر دونوں سنبھال سکتے ہیں۔ دوا چھوڑنا relapse کی سب سے عام وجہ ہے۔

Other Important Conditions

دیگر اہم امراض

- نیند کے عوارض: مسلسل بے خوابی ذہنی صحت کا سبب اور نتیجہ دونوں ہے؛ نیند کی صفائی (sleep hygiene) اور علاج ضروری ہے۔
- خوراک کے عوارض anorexia : اور bulimia جانی خطرہ رکھتے ہیں اور ماہرین کی مشترکہ ٹیم سے علاج ہوتا ہے۔
- بچوں اور نوجوانوں کے عوارض: ADHD، سیکھنے کی مشکلات اور رویّے کے مسائل — بروقت نفسیاتی جانچ سے بہتر نتائج ملتے ہیں۔
- بڑھاپے کے عوارض: ڈیمنشیا اور الزائمر — شروعاتی تشخیص سے پیش رفت سست کی جا سکتی ہے۔

Personality Disorders

شخصی عوارض (Personality Disorders)

شخصی عارضہ وہ گہرا اور پختہ طرزِ فکر و سلوک ہے جو جوانی کے آغاز سے رشتوں، موڈ اور خود شناخت کو مسلسل متاثر کرتا ہے — مثلاً borderline personality disorder میں جذبات کی شدید بے ثباتی اور ترک کئے جانے کا خوف، یا antisocial میں دوسروں کے حقوق کی پامالی۔ نشے کے عادی مریضوں میں شخصی عوارض عام ہیں اور ان کی پہچان علاج کے نتائج کو بہتر بناتی ہے۔ ندا کلینک میں ہر مریض کے لیے نفسیاتی جانچ دستیاب ہے جس میں شخصی عارضہ کی شناخت بھی شامل ہے (باب 5 دیکھیں)۔ علاج میں DBT جیسی خصوصی نفسیاتی علاج مؤثر ہے۔

باب 5

Psychological Assessment - Available for Every Patient

نفسیاتی جانچ — ہر مریض کے لیے دستیاب



درست علاج کی بنیاد درست تشخیص ہے۔ ندا کلینک میں ہر مریض — چاہے ذہنی مرض کا ہو یا نشے کا — معیاری نفسیاتی جانچ سے گزرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ کوئی پاس فیل امتحان نہیں؛ یہ ڈاکٹر اور ماہر نفسیات کی وہ پیمائش ہے جس سے علاج کا نقشہ آپ کے لیے بنایا جاتا ہے۔

نفسیاتی جانچ کے اوزار

شخصیت کے ٹیسٹ	ذہانت کے ٹیسٹ	پروجیکٹو ٹیسٹ
MMPI / MCMI	IQ / WAIS	Rorschach / TAT
ماہر نفسیات کی نگرانی میں	ماہر نفسیات کی نگرانی میں	ماہر نفسیات کی نگرانی میں

نشانیوں کی پیمائش	نفسیاتی جانچ اعصابی	نشے کی شدت کا جائزہ
BDI / BAI / GAD-7	Memory / Attention	ASSIST / AUDIT / DAST
ماہر نفسیات کی نگرانی میں	ماہر نفسیات کی نگرانی میں	ماہر نفسیات کی نگرانی میں

ندا کلینک میں دستیاب نفسیاتی جانچ کے اوزار

What Do We Assess?

کن امور کی جانچ ہوتی ہے؟

- شخصیت کے معیاری ٹیسٹ (MMPI، MCMI): شخصی عوارض کی شناخت — نشے کے مریضوں میں یہ خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ شخصی عارضہ علاج کے انداز کو بدل دیتا ہے۔
- ذہانت اور سیکھنے کی جانچ (IQ / WAIS): بچوں اور بالغوں میں سیکھنے کی مشکلات کی پہچان۔
- پروجیکٹو ٹیسٹ (Rorschach، TAT): بے شعور کے نقوش کو سمجھنے میں معاون۔
- علامات کی پیمائش (BDI، BAI، GAD-7 وغیرہ): ڈپریشن اور اضطراب کی شدت کی پیمائش اور علاج کے اثر کا جائزہ۔
- نشے کی شدت کی جانچ (ASSIST، AUDIT، DAST): استعمال کا نقشہ اور خطرے کا اندازہ۔
- اعصابی-نفسیاتی جانچ: یادداشت، توجہ اور سوچ کی صلاحیتوں کا جائزہ۔

Confidentiality

رازداری

آپ کی جانچ کے نتائج مکمل رازدارانہ ہیں اور صرف آپ کے علاجی ٹیم کے لیے ہیں — یہ PHC کے معیار PRE-5 کا تقاضا اور ہمارا فرض ہے۔

باب 6

Evidence-Based Treatment - Medicines and Psychotherapy

ثبوت پر مبنی علاج — ادویات اور نفسیاتی علاج



جدید نفسیات میں علاج کے دو بڑے ستون ہیں: ادویات اور نفسیاتی علاج (psychotherapy)۔ تحقیق ثابت کرتی ہے کہ زیادہ تر امراض میں دونوں کا امتزاج کسی ایک سے بہتر نتیجہ دیتا ہے۔ کون سا علاج کس کو، کتنا اور کب تک — یہ فیصلہ صرف اہل ماہر کا ہے۔

Medicines

ادویات

- Anti-depressants: ڈپریشن اور اضطراب کے لیے؛ اثر 2 تا 6 ہفتے میں ظاہر ہوتا ہے — یہ عادت پیدا نہیں کرتی، مگر اچانک بند کرنا نقصان دہ ہے۔
- Mood stabilizers: بائی پولر کے لیے۔
- Anti-psychotics: وہم اور ہیلوسینیشن کے لیے۔
- ضدِ اضطراب ادویات: مختصر مدت اور نگرانی میں؛ نیند کی گولیاں اور بینزوڈائزیپائن مسلسل استعمال پر لت پیدا کر سکتی ہیں

(باب 11 دیکھیں)۔

Psychological Therapies

نفسیاتی علاج

- CBT (Cognitive Behavioral Therapy): منفی سوچ کے نقوش پہچان کر بدلنا — ڈپریشن، اضطراب اور لت، تینوں میں مؤثر ترین ثابت شدہ طریقہ۔
- DBT (Dialectical Behavior Therapy): جذبات پر قابو اور رشتوں کی مہارت — شخصی عوارض کے لیے۔
- Motivational Interviewing: تبدیلی کی اندرونی خواہش جگانا — لت کے علاج کا بنیادی اوزار۔
- خاندانی تھراپی: رشتوں کی مرمت اور گھر کا ماحول بہتر بنانا۔
- گروپ تھراپی: ساتھیوں کے تجربے سے سیکھنا — بحالی کا ستون۔

Keep in Mind

یاد رہے

دوا یا تھراپی کوئی جادو کی گولی نہیں؛ یہ معاہدہ ہے — باقاعدگی، صبر اور ماہر کے ساتھ دیانت دارانہ تعاون۔ بیشک کسی بھی دوا میں ترمیم صرف ڈاکٹر کے مشورے سے کریں۔

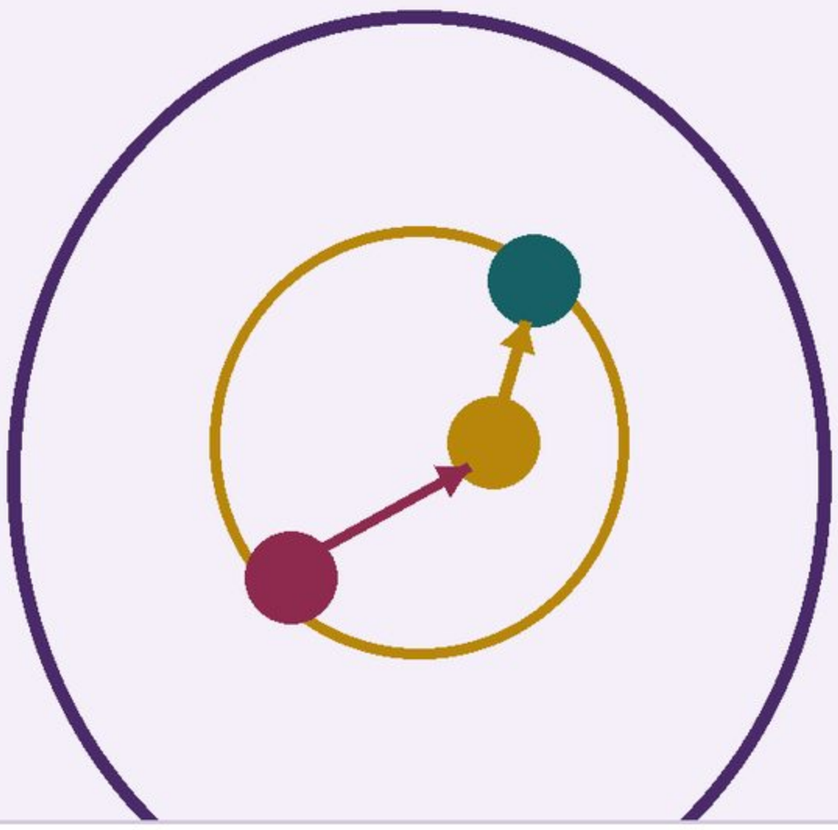
باب 7

What Is Addiction? - An Illness, Not a Weakness

لت کیا ہے؟ — ایک بیماری، کمزوری نہیں

لت (addiction) ایک دائمی مگر علاج پذیر دماغی بیماری ہے جس میں کسی چیز یا عمل کی طاقتور خواہش کے باوجود نقصانات کے سامنے بھی اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ یہ نفس کی کمزوری، کردار کا عیب یا صرف بری عادت نہیں — تحقیق ثابت کرتی ہے کہ منشیات دماغ کے انعامی نظام کی بنیادی کیمیا بدل دیتی ہیں۔

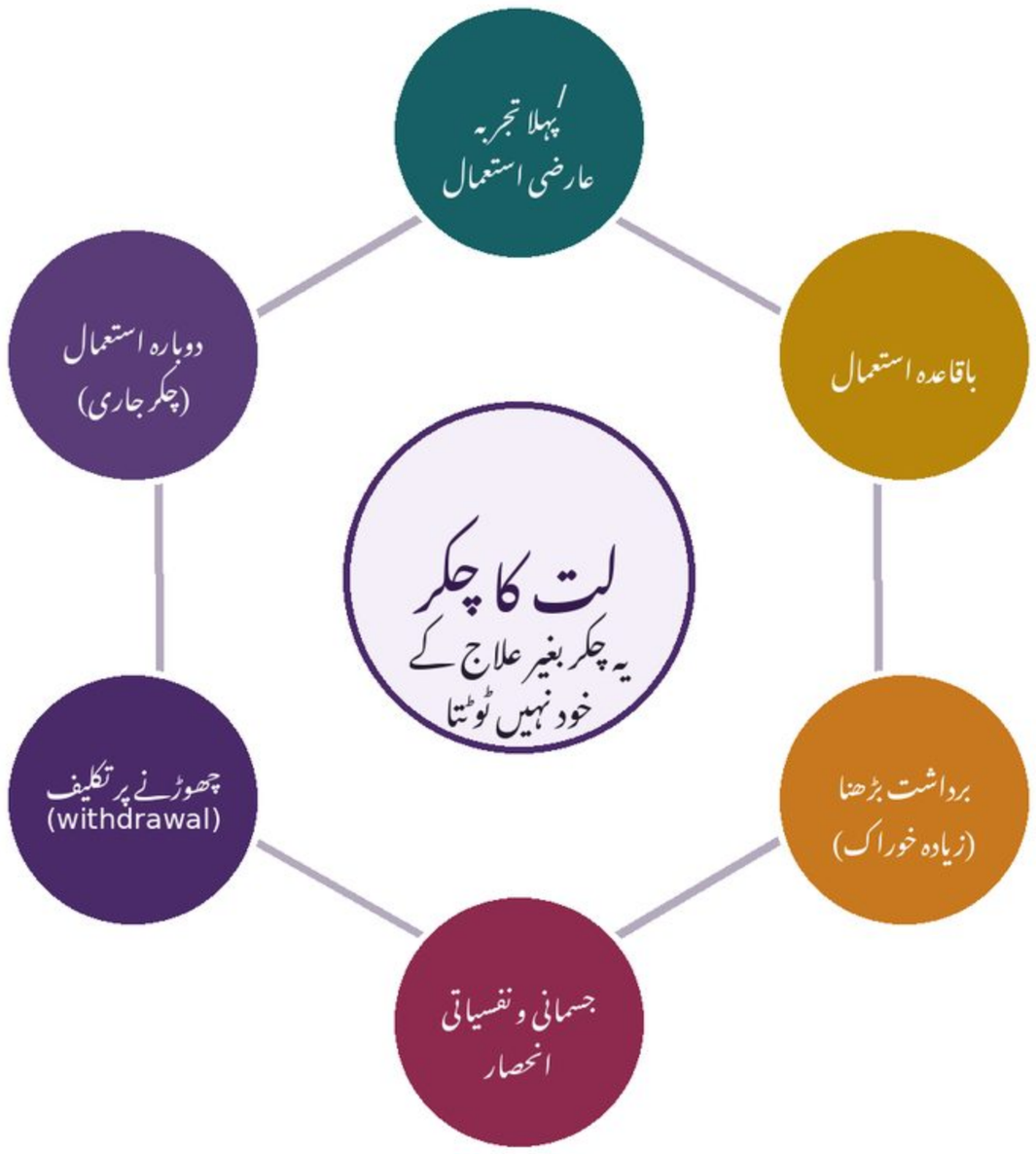
منشیات دماغ کے انعامی نظام کو مغلوب کر دیتی ہیں



منشیات dopamine کی اچانک اور غیر فطری کثرت پیدا کرتی ہیں۔ وقت کے ساتھ دماغ کی حساسیت کم ہو جاتی ہے (برداشت) اور خواہش (craving) بڑھتی جاتی ہے — یہی لت کی دماغی بنیاد ہے۔

منشیات دماغ کے انعامی نظام (dopamine pathway) کو کیسے مغلوب کرتی ہیں

شروع میں نشہ ایک انتخاب ہوتا ہے، مگر بار بار استعمال سے دماغ کا توازن بگڑتا ہے: پہلے جتنی خوشی ملتی تھی اب اتنی ہی مقدار سے نہیں ملتی (برداشت)، پھر نشے کے بغیر جسم و ذہن تکلیف میں رہتا ہے (انحصار)، اور خواہش اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے کہ فیصلہ کرنے والا حصہ (prefrontal cortex) اس کے آگے کمزور پڑ جاتا ہے۔



لت کا چکر — علاج اس چکر کو کسی بھی مرحلے پر توڑ سکتا ہے

Recognizing Addiction - Key Signs

لت کی پہچان — اہم علامات

- عہد کے باوجود روک نہ سکنا؛ ارادے سے زیادہ مقدار یا مدت تک استعمال۔
- کام، پڑھائی، گھر اور رشتے نظر انداز ہوتے جانا۔
- خطرات جانتے ہوئے بھی استعمال جاری رکھنا۔
- چھوڑنے پر بے چینی، کانپنا، پسینہ، غصہ یا بیماری (withdrawal)۔
- نشے کے حصول، استعمال اور اثر سے نمٹنے میں دن کا بڑا حصہ۔
- رازداری، جھوٹ، پیسوں کی غیر معمولی طلب یا چوری۔

For the Family

خاندان کے لیے

اگر آپ کے عزیز میں یہ علامات ہیں تو انہیں بدتمیز یا لاپرواہ نہ کہیں — یہ علامتیں بیماری کی ہیں۔ انکار (denial) خود بیماری کا حصہ ہے۔ صبر، محبت اور ماہر کی مدد سے انکار ٹوٹتا ہے۔

باب 8

Drug Use in Pakistan and the World

پاکستان اور دنیا میں نشے کی صورتحال



اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم (UNODC) کی قومی سروے Drug Use in Pakistan کے مطابق پاکستان میں 15 تا 64 سال کی عمر کے تقریباً 64 لاکھ (6.45 million) افراد — یعنی تقریباً ہر سترہواں شخص — کسی نہ کسی نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سروے پاکستان کی آخری مکمل قومی سروے ہے؛ نئی قومی سروے (2022-24) کا آغاز ہو چکا ہے۔

شعبہ	پاکستان (UNODC 2013)	امریکہ (SAMHSA 2024)	یورپ (EUDA 2025)
مجموعی استعمال	تقریباً 64 لاکھ افراد (15-64 سال) — 5.8 فیصد	گزشتہ سال 73.6 ملین افراد (12+ سال)	بھنگ سب سے عام؛ کوکین دوسرے نمبر پر
سب سے عام نشہ	بھنگ خاندان — تقریباً 40 لاکھ افراد	ماریجوانا — 64.2 ملین افراد	بھنگ (cannabis)
افیونی اشیاء	ہیروئن و افیون ~10 لاکھ؛ نسخے کی دوریانہ ادویات ~17 لاکھ	نسخے کی opioid ادویات کا غلط استعمال 7.6 ملین	ہیروئن کم مگر مصنوعی opioids بڑھ رہی ہیں

انجیکشن استعمال	تقریباً 4.2 لاکھ افراد؛ تقریباً تین چوتھائی سوئیاں بانٹتے ہیں	—	—
نیا خطرہ	آئس/کرسٹل میتھ تیزی سے پھیل رہی ہے — خاص طور پر نوجوانوں اور طلبہ میں	میتھ اور فینٹینل سے وافر اموات	مصنوعی منشیات میں اضافہ

The Treatment Gap

علاج تک رسائی کا بحران

یہی سروے بتاتی ہے کہ باقاعدہ افیون استعمال کرنے والوں کی تین چوتھائی سے زیادہ مدد چاہتے ہیں مگر انہیں نہیں مل پاتی؛ لاگت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ملک بھر میں منظم علاج سالانہ زیادہ سے زیادہ تقریباً 30 ہزار افراد تک پہنچتا ہے — یعنی سینکڑوں ہزار خاندان تنہا جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہی وہ خلا ہے جسے ندا کلینک 1999 سے پُر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

Khyber Pakhtunkhwa and Punjab

خیبر پختونخوا اور پنجاب

سروے کے مطابق سب سے زیادہ شرح خیبر پختونخوا 11) فیصد) میں ہے، پھر سندھ 6.5) فیصد)، بلوچستان 5.1) فیصد) اور پنجاب 4.8) فیصد — تقریباً 29 لاکھ افراد) میں۔ لاہور سمیت بڑے شہروں میں آئس اور ہیروئن دونوں بڑے مسئلے ہیں۔

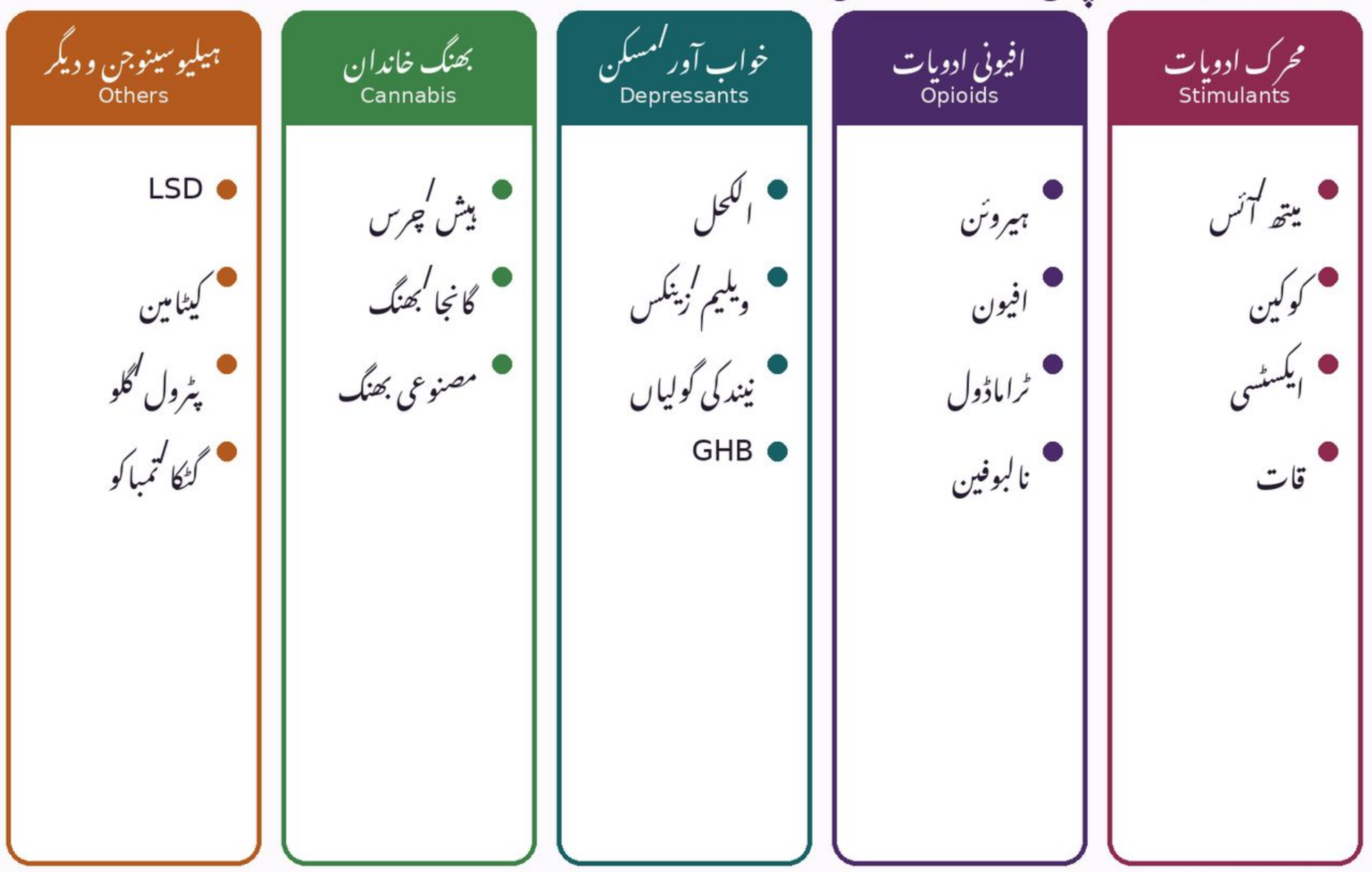
باب 9
Drugs of Abuse - Stimulants

نشہ آور اشیاء — محرک ادویات (Stimulants)



یہ اشیاء اعصابی نظام کو تیز کرتی ہیں: توانائی، بے خوابی اور خود اعتمادی کا عارضی احساس — اور پھر شدید گراوٹ۔ ان میں آئس پاکستان کے لیے آج کا سب سے تیز خطرہ ہے۔

نشہ آور اشیاء کے پانچ بڑے خاندان



ہر خاندان کا دماغ پر اثر مختلف ہے، مگر ہر ایک لت پیدا کر سکتا ہے۔

نشہ آور اشیاء کے پانچ بڑے خاندان — ایک نظر میں

دوا (English)	مقامی / گلی کے نام	طریقہ استعمال	اہم خطرات
آئس / کرسٹل میتھ (Methamphetamine)	شیشہ، آئس، ٹک، کرسٹل	پائپ میں پینا، سونگھنا، انجیکشن	ذہنی پریشانی و خیال آوری، بے خوابی، دانت گلنا، دل کا دورہ، انتہائی لت
کوکین (Cocaine)	کوک، چٹا، برف	سونگھنا، انجیکشن	دل اور دماغی دورے، ناک کے ٹشو کا نقصان، مہنگی لت
کریک کوکین (Crack)	کریک، پتھر	پینا (smoking)	سیکنڈوں میں نشہ اور فوری شدید لت
ایکسٹسی MDMA /	مولی، E، ایکس	گولی نگلنا	جسمانی حرارت بڑھنا، پانی کی خرابی، شدید ڈپریشن کے ادوار
ایمفیٹامین (Amphetamine)	اسپیڈ	گولی، سونگھنا	بے خوابی، بھوک ختم ہونا، پریشانی
قات (Khat)	قات، چاٹ	تازہ پتیاں چبانا	محرک اثر، مسوڑھوں اور معدے کی بیماری، نفسیاتی لت

Ice (Crystal Meth) - A Special Warning

آئس — خاص انتباہ

لاہور سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں آئس تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ سستی، آسانی سے دستیاب اور نہایت تباہ کن ہے: چند ہی ہفتوں میں بے خوابی، وزن کا گھٹنا، خیال آوری (پرانویا) اور تشدد تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کے withdrawal کے دوران گہری ڈپریشن اور خودکشی کا خطرہ ہوتا ہے — چھڑوانا ضرور، مگر ماہر کی نگرانی میں۔

باب 10
Drugs of Abuse - Opioids

نشہ آور اشیاء — افیونی ادویات (Opioids)



یہ درد کم کرتی ہیں اور سکون دیتی ہیں، مگر ان کی لت سب سے تیز اور ان کا overdose سب سے خطرناک ہے — سانس رک سکتا ہے۔ پاکستان میں یہ سب سے بڑا علاج طلب گروہ ہے۔

دوا (English)	مقامی / گلی کے نام	طریقہ استعمال	اہم خطرات
ہیروئن (Heroin)	سماک، براؤن شوگر، کالا، پاؤڈر	سونگھنا، رقاق پینا (chasing)، انجیکشن	overdose سے سانس رکنا، HIV اور ہیپاٹائٹس C (مشترکہ سوئی)، شدید لت
افیون (Opium)	افیم، امبل، ٹوکری	کھانا، چائے میں گھول کر پینا	سانس کی کمی، قبض، دھیلا پن، لت
مارفین (Morphine)	مارفین	گولی، انجیکشن	overdose سے سانس رکنا
نالبوفین (Nalbuphine)	کنز (Kinz) انجیکشن	انجیکشن — اکثر مشترکہ سوئی سے	تیز لت، سوئی کے زخم، HIV و ہیپاٹائٹس C، سانس رکنا

ٹراماڈول (Tramadol)	ٹرامی، ٹنول	گولی	دورے (fits)، (دوسری ادویات کے ساتھ خطرناک، لت
کوڈین شربت (Codeine syrup)	کوڈین سائروپ	پینا	گہری نیند، سانس کی کمی، لت
فینٹینل (Fentanyl)	فینٹ	پیچ، انجیکشن	ہیروئن سے کئی گنا طاقتور — معمولی زیادتی بھی جان لیوا
بوپرینورفین (Buprenorphine)	سبیوکسون	گولی، انجیکشن	الکحل یا نیند کی ادویات کے ساتھ overdose
پینٹازوسین (Pentazocine)	فورٹون (Fortwin) انجیکشن	انجیکشن	سوئی کے زخم و ابسیس، لت
میتھاڈون (بغیر نگرانی)	میتھاڈون	پینا	overdose — یہ صرف اہل ڈاکٹر کے پروگرام میں دی جاتی ہے

The Danger of Shared Needles

مشترکہ سوئی کا خطرہ

انجیکشن استعمال کرنے والوں میں سوئی بانٹنا HIV اور ہیپاٹائٹس C کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ندا کلینک میں مریضوں کی ان بیماریوں کی جانچ اور رہنمائی علاج کا حصہ ہے۔

باب 11

Drugs of Abuse - Depressants

نشہ آور اشیاء — مسکن و خواب آور ادویات (Depressants)



یہ اشیاء اعصابی نظام کو سست کرتی ہیں: سکون، نیند اور بے فکری — مگر ان کا اچانک خاتمہ (خصوصاً الکحل اور نیند/سکون کی ادویات) جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ ادویات ڈاکٹر کے نسخے کی بھی ہوں تو مسلسل بے نگرانی استعمال لت بنا دیتا ہے۔

دوا (English)	مقامی / گلی کے نام	طریقہ استعمال	اہم خطرات
الکحل (Alcohol)	شراب، دیسی شراب، مدرا	پینا	جگر کی بیماری، حادثے و تشدد، اچانک چھوڑنے پر دورے و موت کا خطرہ
الپرازولم (Alprazolam)	زینکس (Xanax)	گولی	تیز لت، یادداشت کا نقصان، حادثے؛ اچانک بند کرنا خطرناک
ڈائزیپام (Diazepam)	ویلیم (Valium)	گولی	لت، چکر، دوسری مسکن ادویات کے ساتھ overdose
برومازیپام (Bromazepam)	لیکسوٹینل (Lexotanil)	گولی	وہی خطرات — لمبا استعمال لت بناتا ہے

مڈازولم (Midazolam)	ڈورمیکم (Dormicum)	گولی، انجیکشن	گہری بے ہوشی اور سانس رکنا — صرف طبی نگرانی میں
نیند کی ادویات (Zolpidem وغیرہ)	نیند کی گولیاں	گولی	نیند میں چلنا پھرنا، لت
پریگابالن (Pregabalin)	لائرکا (Lyrica)	کیپسول	چکر، وزن، opioids کے ساتھ overdose
باربیچوریٹس (Barbiturates)	باربز	گولی	overdose نہایت آسان — پرانی مگر خطرناک
GHB	لیکوڈ ایکسٹسی، G	پینا	بے ہوشی، سانس رکنا، تشدد کے واقعات میں استعمال

The Danger of Stopping Alcohol Suddenly

الکحل چھوڑنے کا خطرہ

باقاعدہ بھاری استعمال کے بعد الکحل یا بینزوڈائزیپائن اچانک بند کرنا دورے (fits) اور delirium tremens کا سبب بن سکتا ہے — یہ ایمرجنسی ہے۔ ایسے مریضوں کا ڈی ٹاکس ہمیشہ طبی نگرانی میں ہو۔

باب 12

Cannabis, Hallucinogens and Other Substances

بھنگ خاندان، ہیلیوسینوجن اور دیگر اشیاء



Cannabis

بھنگ خاندان (Cannabis)

دوا (English)	مقامی / گلی کے نام	طریقہ استعمال	اہم خطرات
چرس / ہیش (Hashish)	چرس، ہیش، گردا	سگریٹ یا ہکے میں پینا	یادداشت و توجہ میں کمی، پڑھائی اور کام متاثر، کچھ افراد میں سائیکوسس کا خطرہ
گانجا و بھنگ (Marijuana / Bhang)	گانجا، بھنگ (ٹھنڈائی)	پینا، کھانا یا پینا	وہی خطرات؛ بھنگ کے مشروب کا اثر دیر سے اور زیادہ دیر تک
مصنوعی بھنگ (Synthetic cannabinoids)	سپائس، K2	پینا	غیر متوقع اور زہریلا — سائیکوسس، گردوں کا نقصان

چرس پاکستان کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی غیر قانونی شے ہے – UNODC سروے کے مطابق تقریباً 40 لاکھ صارف۔ یہ تو صرف چرس ہے والی بات غلط ہے: باقاعدہ استعمال حوصلہ، یادداشت اور ذہنی توازن کو نقصان دیتا ہے اور نوجوانوں میں ذہنی امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے۔

Hallucinogens and Others

ہیلیوسینوجن اور دیگر

دوا (English)	مقامی / گلی کے نام	طریقہ استعمال	اہم خطرات
LSD	ایسڈ	چھوٹی گولی یا کاغذ	خوفناک تجربے (bad trip)، فلیش بیک، جوکھم بھرے رویے
جادوئی مشروم (Psilocybin)	شومز	کھانا	وہی — مگر شدت غیر متوقع
کیٹامین (Ketamine)	کیٹ، Special K	سونگھنا، انجیکشن	مثانے کی سنگین بیماری، بے ہوشی، لت
سونگھنے والی اشیاء (Inhalants)	سماڈ بانڈ، گلو، پٹرول	سانس میں سونگھنا	دماغ کا مستقل نقصان، اچانک موت — بچوں میں بھی پایا جاتا ہے
تمباکو / nicotine	سگریٹ، بیڑی، شیشہ، نصوار	پینا یا چبانا	مضبوط لت، کینسر، دل اور پھیپھڑوں کی بیماری
گٹکا / پان مسالہ	گٹکا، مین پوری	چبانا	منہ کا کینسر، لت

Note

نوٹ

اس فہرست میں ہر وہ شے شامل ہے جو ہم اپنے مریضوں میں عام دیکھتے ہیں۔ کسی بھی شے کے استعمال کی نشاندہی ہو تو سزا نہیں، تشخیص اور علاج چاہیے۔

باب 13

Withdrawal and Detox - The First Step

وٹھ ڈرال اور ڈی ٹاکس — پہلا قدم



جسم جب کسی نشے کا عادی ہو جائے تو اس کے بغیر تکلیف دہ علامات آتی ہیں — اسے withdrawal کہتے ہیں۔ ڈی ٹاکس (detoxification) یہی مرحلہ ہے: طبی نگرانی میں جسم کو محفوظ طریقے سے نشے سے صاف کرنا۔

Common Withdrawal Symptoms

عام علامات

- افیونی (ہیروئن وغیرہ): دردِ بدن، ناک بہنا، بے چینی، اسہال، بے خوابی — نہایت تکلیف دہ مگر عموماً جان لیوا نہیں۔
- الکحل اور نیند/سکون کی ادویات: کانپنا، پسینہ، دل کی دھڑکن، دورے اور delirium — جان لیوا ہو سکتا ہے؛ کبھی گھر پر اچانک نہ بند کریں۔
- محرک (آئس وغیرہ): گہری اداسی، تھکن، بھوک، بورے خواب — خودکشی کے خیالات کا خطرہ۔

ڈی ٹاکس علاج کی تکمیل نہیں، صرف آغاز ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ صرف ڈی ٹاکس کے بعد بغیر بحالی پروگرام کے واپسی کی شرح بہت بلند ہے۔ ندا کلینک میں ڈی ٹاکس کے بعد مکمل علاجی پروگرام (باب 16) شروع ہوتا ہے۔

For the Family

خاندان کے لیے

ڈی ٹاکس کے دنوں میں مریض بے چین، چڑچڑا اور ناراض ہو سکتا ہے — یہ بیماری کی علامت ہے، آپ سے دشمنی نہیں۔ آپ کا حوصلہ اس مرحلے میں سب سے قیمتی دوا ہے۔

باب 14

Evidence-Based Treatment Approaches

ثبوت پر مبنی علاج کے طریقے



لت کا مؤثر علاج کوئی ایک چیز نہیں بلکہ ایک مکمل نظام ہے۔ امریکی ادارہ NIDA (National Institute on Drug Abuse) کی تحقیقی اصولوں کے مطابق: لت علاج پذیر دماغی بیماری ہے؛ ہر مریض کے لیے ایک ہی نسخہ نہیں چلتا؛ علاج صرف نشہ نہیں بلکہ مریض کی مجموعی ضروریات (جسمانی، نفسیاتی، سماجی) کو دیکھتا ہے؛ علاج کا کافی عرصہ نہایت اہم ہے؛ اور relapse ناکامی نہیں بلکہ علاج میں ترمیم کی علامت ہے۔

Main Forms of Treatment

علاج کی بنیادی شکلیں

- طبی ڈی ٹاکس: محفوظ اور نگرانی میں نشے سے پاکی — علاج کا پہلا مرحلہ۔
- رہائشی علاج (residential): ماحول سے دور، منظم زندگی میں گہری بحالی — شدید لت اور بار بار واپسی پر بہترین۔
- بیرونی پروگرام (outpatient/OPD): گھر رہتے ہوئے مقررہ سیشن — ہلکی لت اور aftercare کے لیے۔
- ادویات معاونتِ علاج (MAT): افیونی لت میں میتھاڈون، بوپرینورفین اور نالٹریکسون اہل ڈاکٹر کی نگرانی میں cravings کم کر

کے بحالی میں مدد دیتے ہیں — یہ ایک نشے سے دوسرا نشہ نہیں بلکہ ثابت شدہ طبی علاج ہے۔

- نفسیاتی علاج: CBT، Interviewing Motivational، contingency management اور بارہ اقدامات کی رہنمائی Facilitation (Twelve-Step)۔
- مسلسل نگہداشت (aftercare): علاج کے بعد مہینوں تک رابطہ، سپورٹ گروپ اور relapse prevention کا منصوبہ۔

Dual Diagnosis

دوہرا مرض (Dual Diagnosis)

تقریباً آدھے نشے کے مریضوں کے ساتھ ڈپریشن، اضطراب، PTSD یا کوئی اور ذہنی مرض بھی ہوتا ہے — اور اس کے برعکس بھی۔ جب تک دونوں کا ایک ساتھ علاج نہ ہو، دونوں واپس آتے رہتے ہیں۔ ندا کلینک میں تشخیصی مرحلے میں یہ جانچ لازمی ہے۔

باب 15

The Minnesota Model and Hazelden - Nida Clinic's Treatment Approach

منی سوٹا ماڈل اور ہیزلڈن — ندا کلینک کا طریقۂ علاج



منی سوٹا ماڈل (Minnesota Model) دنیا کا سب سے مؤثر اور مقبول رہائشی علاجی نمونہ ہے۔ یہ 1949 میں امریکی ریاست منی سوٹا کے ہیزلڈن (Hazelden) ادارے سے شروع ہوا اور آج Hazelden Betty Ford Foundation اس کا عالمی مرکز ہے۔ ندا کلینک اسی ماڈل کو پاکستانی ثقافت اور PHC معیارات کے ساتھ اپناتا ہے۔



منی سوٹا ماڈل کے بنیادی ستون

Principles of the Model

ماڈل کے اصول

- لت ایک بیماری ہے — مریض لعنت نہیں، علاج کا حقدار ہے۔
- مکمل پرہیز (abstinence) مقصد ہے، اور اس کا راستہ بارہ اقدامات سے گزرتا ہے۔
- کثیر الشعبہ ٹیم: ڈاکٹر، ماہر امراض نفسیات، ماہر نفسیات، کاؤنسلر اور بحالی یافتہ رہنما سب مل کر کام کرتے ہیں۔
- گروپ تھراپی مرکزی اوزار ہے: ساتھی مریض ایک دوسرے کے آئینے اور حوصلہ بنتے ہیں۔
- خاندان علاج کا حصہ ہے — الگ سیشن اور تعلیم کے ساتھ۔
- علاج مریض کے جسم، ذہن، روح اور رشتوں — چاروں کی شفا کو دیکھتا ہے۔
- رہائی کے بعد بھی رشتہ قائم رہتا ہے aftercare : اور سپورٹ گروپ۔

International Evidence

بین الاقوامی ثبوت

منی سوٹا ماڈل پر دہائیوں کی تحقیق اور لاکھوں بحالی یافتہ افراد گواہ ہیں۔ ہیزلڈن کے تجربے اور اس کی شاخوں نے دنیا بھر کے علاجی مراکز — جن میں ندا کلینک بھی شامل ہے — کو یہ معیار دیا۔

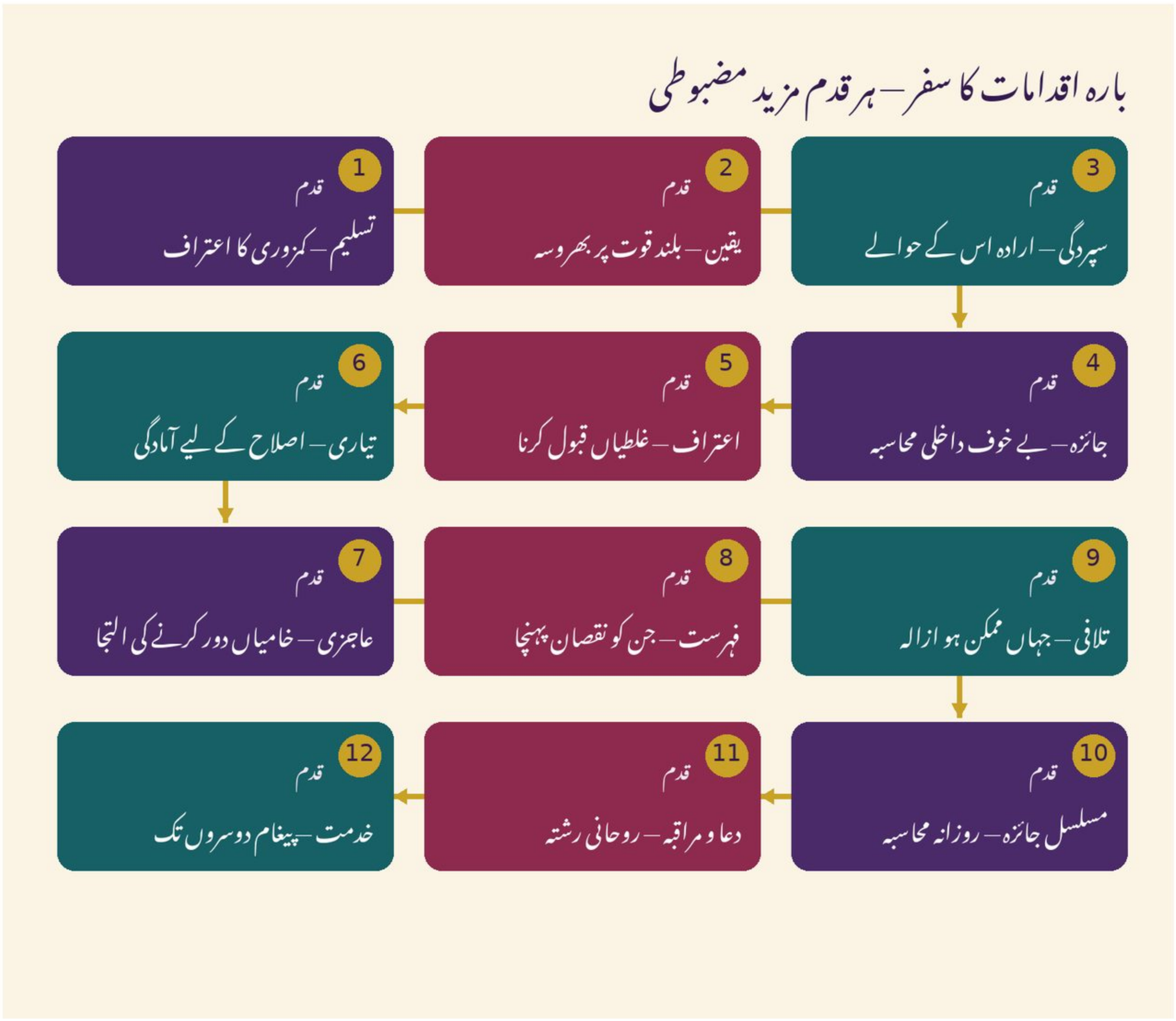
باب 16

The Twelve Steps - A Roadmap to Recovery

بارہ اقدامات — بحالی کا نقشہ



بارہ اقدامات (Twelve Steps) الکحلکس اینانمس (AA) کی 1935 کی تحریک سے شروع ہوئے اور آج Narcotics Anonymous (NA) سمیت دنیا بھر کے لاکھوں افراد کی بحالی کی بنیاد ہیں۔ یہ کوئی مذہبی نظریہ نہیں بلکہ خود احتسابی، تسلیم، تلافی اور خدمت کا عملی راستہ ہے، جو ہر عقیدے کے شخص کے لیے کھلا ہے۔



بارہ اقدامات — ایک نظر میں

An Educational Summary of the Steps

اقدامات کا تعلیمی خلاصہ

- قدم 1 — تسلیم: ماننا کہ نشے کے آگے ہم بے بس ہیں اور زندگی بے قابو ہو چکی ہے۔
- قدم 2 — یقین: ایمان لانا کہ ہم سے بڑی قوت ہمیں صحت مندی لوٹا سکتی ہے۔
- قدم 3 — سپردگی: اپنی خواہش اور زندگی کا فیصلہ اس بلند قوت (خدا — جیسے ہر شخص اسے سمجھے) کے حوالے کرنا۔
- قدم 4 — جائزہ: اپنے کردار کا بے خوف اخلاقی جائزہ لینا۔
- قدم 5 — اعتراف: خدا، اپنے آپ اور کسی ایک بھروسے مند کے سامنے اپنی غلطیوں کی صحیح نوعیت ماننا۔
- قدم 6 — تیاری: ان خامیاں دور کرانے کے لیے پوری طرح آمادہ ہونا۔
- قدم 7 — عاجزی: عاجزی سے اپنی کمزوریوں کے ازالے کی التجا کرنا۔
- قدم 8 — فہرست: ان سب کی فہرست بنانا جنہیں ہم نے نقصان پہنچایا، اور تلافی پر آمادہ ہونا۔
- قدم 9 — تلافی: جہاں تک ممکن ہو براہ راست تلافی کرنا — بشرطیکہ اس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔

- قدم 10 — مسلسل جائزہ: روزانہ احتساب جاری رکھنا اور غلطی فوراً ماننا۔
- قدم 11 — دعا و مراقبہ: دعا اور مراقبے سے اس بلند قوت سے شعوری رابطہ مضبوط کرنا۔
- قدم 12 — خدمت: روحانی بیداری کے بعد یہ پیغام دوسرے عادی افراد تک پہنچانا اور یہ اصول ہر معاملے میں اپنانا۔

Attribution

حوالہ

یہ AA کے بارہ اقدامات کا تعلیمی اردو خلاصہ ہے؛ اصل متن aa.org پر اور NA کے متعلق na.org پر دستیاب ہے۔ ندا کلینک میں یہ اقدامات تربیت یافتہ کاؤنسلرز کی رہنمائی میں گروپ اور انفرادی سیشنز میں عملاً کرائے جاتے ہیں۔

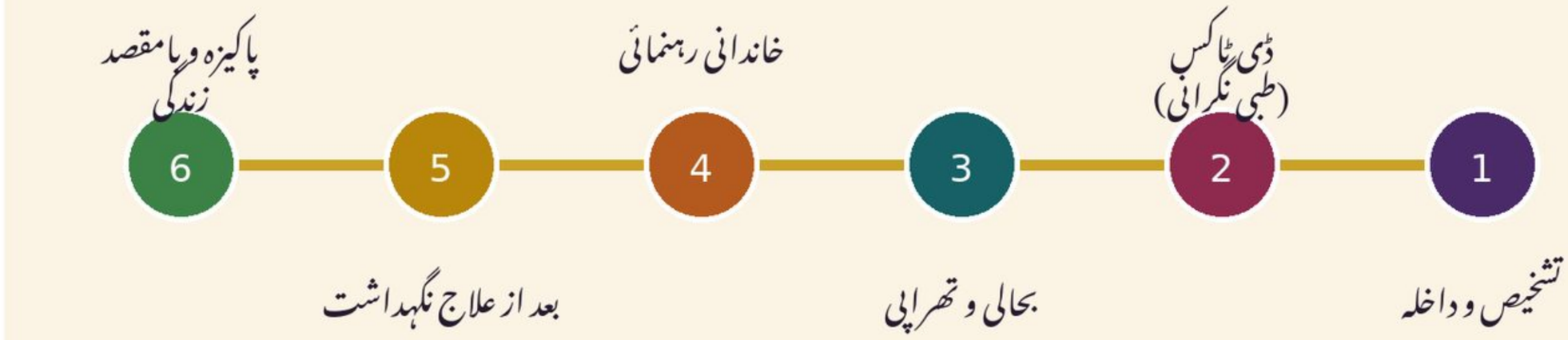
باب 17

Nida Clinic's Treatment Programme - Step by Step

ندا کلینک کا علاجی پروگرام — قدم بہ قدم



ندا کلینک کا پروگرام منی سوٹا ماڈل، بارہ اقدامات اور PHC کے معیارات کو ملا کر بنا ہے۔ ہر مریض کا نقشہ اس کی تشخیص کے مطابق ہوتا ہے، مگر سفر کا خاکہ یہ ہے:



علاج کے مراحل — تشخیص سے پاکیزہ زندگی تک

Stage 1: Assessment and Admission

مرحلہ 1: تشخیص اور داخلہ

- مکمل طبی اور نفسیاتی جائزہ: تاریخ، معائنہ اور ضروری لیبارٹری ٹیسٹ۔
- معیاری نفسیاتی ٹیسٹنگ — بشمول شخصی عارضہ کی شناخت (باب 5)۔
- باخبر رضامندی اور لاگت کی مکمل وضاحت (PHC معیار PRE-2 اور PRE-3)۔
- خاندان سے تعارفی نشست اور توقعات کی وضاحت۔

Stage 2: Detox (Under Medical Supervision)

مرحلہ 2: ڈی ٹاکس (طبی نگرانی میں)

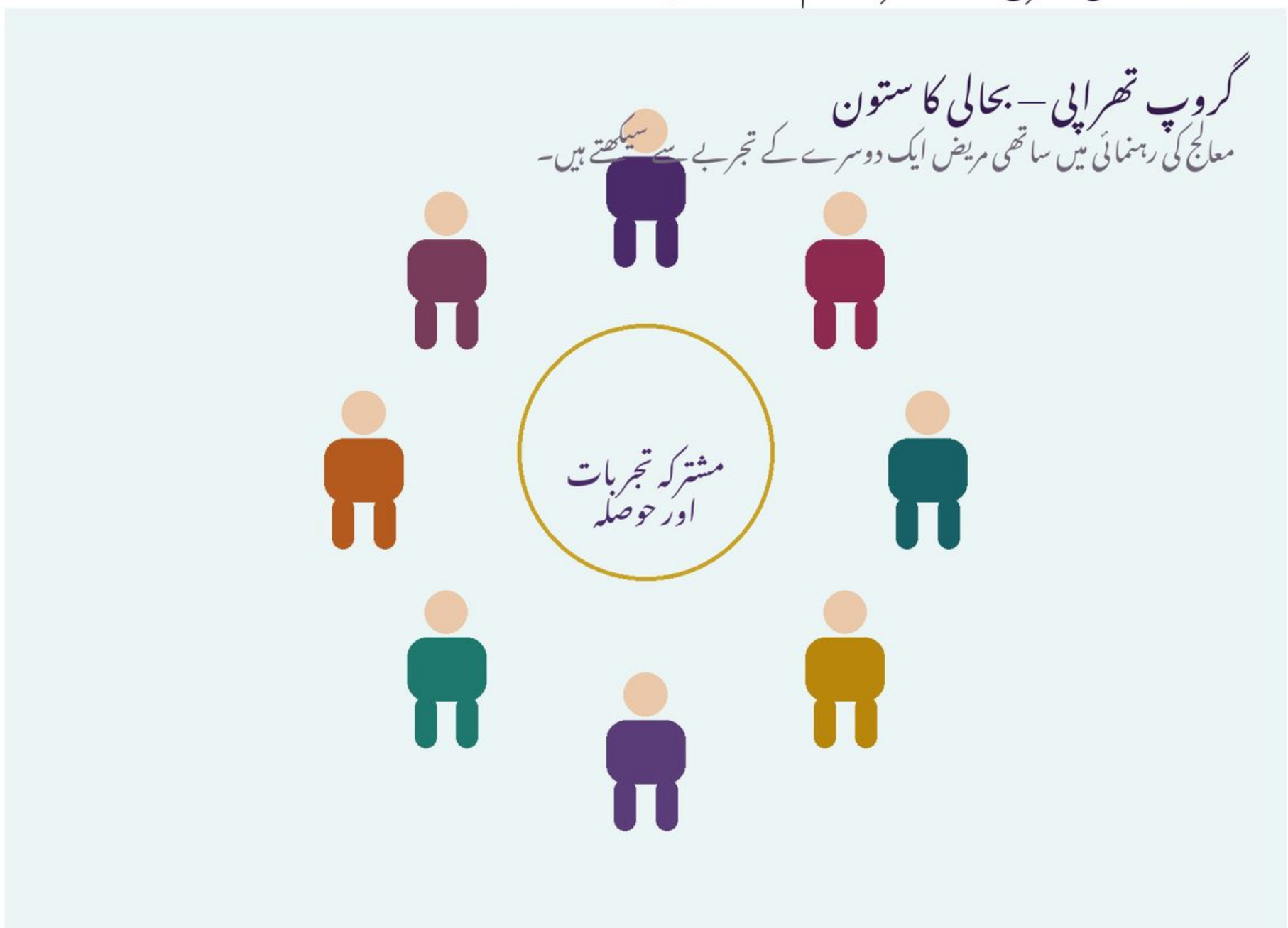
ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں محفوظ ڈی ٹاکس، جس میں withdrawal کی علامات کی مکمل دیکھ بھال، خوراک اور نیند کا نظم شامل ہے (باب 13)۔

Stage 3: Rehabilitation - The Core Therapy Phase

مرحلہ 3: بحالی — تھراپی کا مرکزی مرحلہ

- روزانہ گروپ تھراپی: مشترکہ تجربات سے سیکھنا اور انکار کو توڑنا۔
- انفرادی کاؤنسلنگ: ذاتی بنیادی وجوہات (صدمے، رشتے، دباؤ) پر کام۔
- بارہ اقدامات کا عملی کام: اقدام 1 تا 5 ابتدائی رہائش میں۔

- خاندانی سیشن: رشتوں کی مرمت اور گھر کے ماحول کی تیاری۔
- صحت مند مشغلے: ورزش، تفریح اور روزمرہ کا نظم (PHC معیار ROM-3)۔



گروپ تھراپی — ساتھیوں کے تجربے سے بحالی

Stage 4: Aftercare

مرحلہ 4: بعد از علاج نگہداشت (Aftercare)

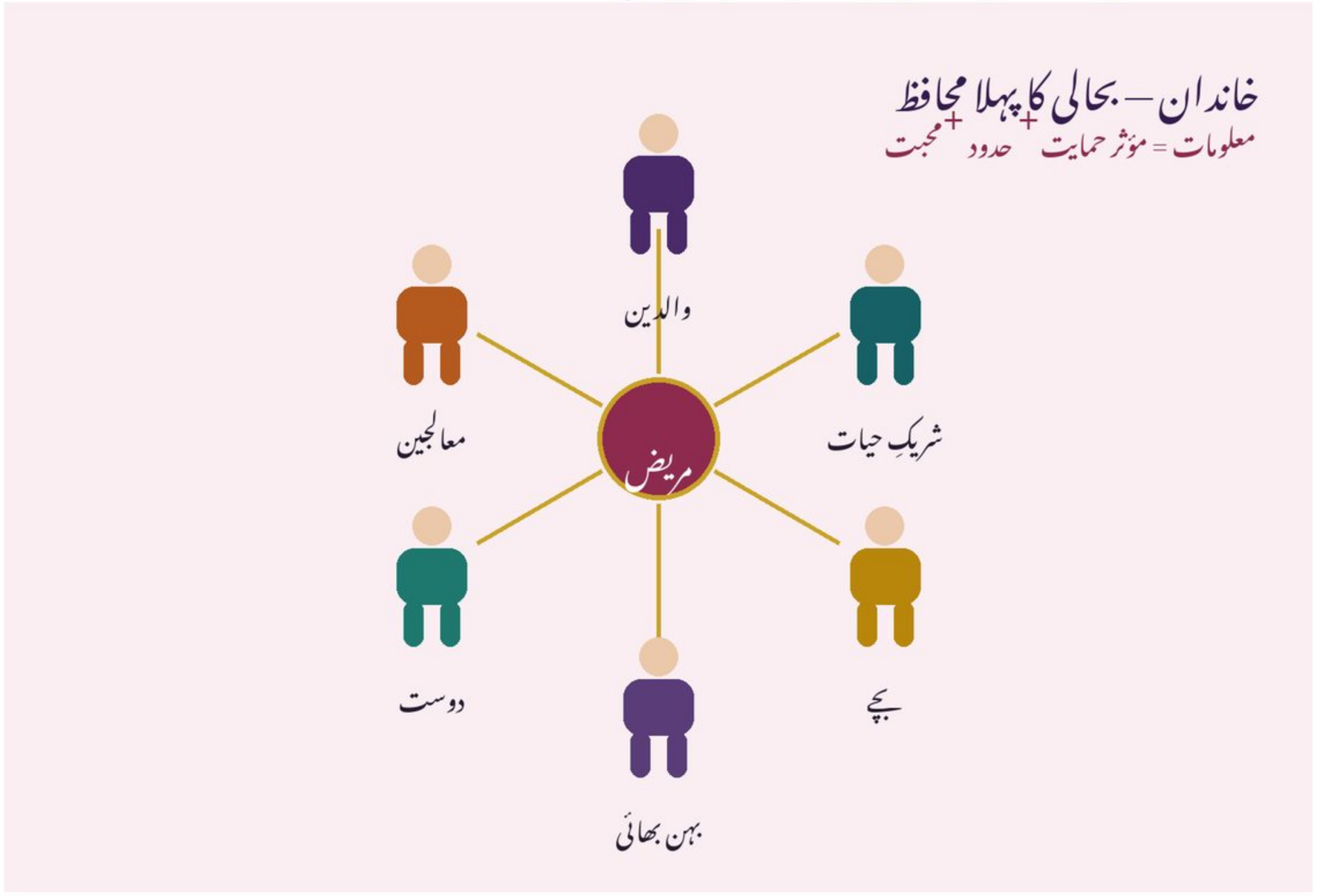
- رہائی سے پہلے ذاتی relapse prevention منصوبہ: خطرناک صورتحالوں کی پہچان اور نمٹنے کے طریقے۔
- مقررہ فالو اپ ملاقاتیں اور فون رابطہ۔
- سپورٹ گروپ (بارہ اقداماتی میٹنگز) سے مستقل رابطے کی رہنمائی۔
- خاندان کے لیے مسلسل رہنمائی۔

باب 18

The Family's Role - Recovery's First Guardian

خاندان کا کردار — بحالی کا پہلا محافظ

لت کو خاندانی بیماری کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پورے گھر کو متاثر کرتی ہے — اور بحالی بھی گھر سے ہی پھیلتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ خاندان کی مؤثر شمولیت علاج کے نتائج کو نمایاں طور پر بہتر بناتی ہے۔



خاندان کا دائرۂ حمایت

What Families Should Do

خاندان کیا کرے

- بیماری سمجھیں: پڑھیں، پوچھیں، ماہر سے سیکھیں — الزام کی جگہ معلومات لے لیں۔
- حدود قائم کریں: محبت کے ساتھ نہیں کہنا سیکھیں؛ پیسے، جھوٹ اور غلطیوں کو مہمیز (enabling) نہ بنیں۔
- بات چیت کا راستہ کھلا رکھیں: شرمانے اور ڈرانے کے بجائے سنیں اور سمجھیں۔
- اپنی دیکھ بھال کریں: والدین اور شریکِ حیات کے لیے بھی کاؤنسلنگ اور Al-Anon طرز کے سپورٹ گروپ مددگار ہیں۔
- علاج میں ساتھ دیں: خاندانی سیشنز میں شرکت اور فالو اپ کی پابندی۔

What Families Should Not Do

خاندان کیا نہ کرے

- نشے کے پیسے نہ دیں، قرضے نہ ادا کریں، جھوٹ نہ چھپائیں — یہ مرض کو آگے بڑھاتا ہے۔
- ذلیل، تشدد یا گھر سے نکالنے کی دھمکی بحالی نہیں لاتے؛ باعزت سختی لا سکتی ہے۔
- رہائی کے فوراً بعد اب سب ٹھیک ہے کا فرض نہ کریں — بحالی مہینوں کا سفر ہے۔

Relapse Prevention

Relapse (واپسی) سے بچاؤ

واپسی ناکامی نہیں؛ یہ علاج میں ترمیم کا اشارہ ہے۔ عام محرکات: پرانے دوست اور مقامات، دباؤ، اداسی، خوشی کے مواقع اور ایک بار سے کیا ہوتا ہے والی سوچ۔ احتیاط: محرکات سے بچنا، روزانہ کا نظم، سپورٹ گروپ اور پہلی لغزش پر فوری رابطہ — ڈاکٹر یا کلینک سے، شرم کے بغیر۔

Emergency

ایمرجنسی

overdose کی علامات: گہری بے ہوشی، سانس کی سستی یا رکنا، ہونٹ نیلے ہونا۔ فوراً ایمرجنسی مدد لیں، مریض کو پہلو پر لٹائیں اور سوئی/دوا کا نام یا لفافہ ساتھ رکھیں۔ ہر سیکنڈ اہم ہے۔

باب 19

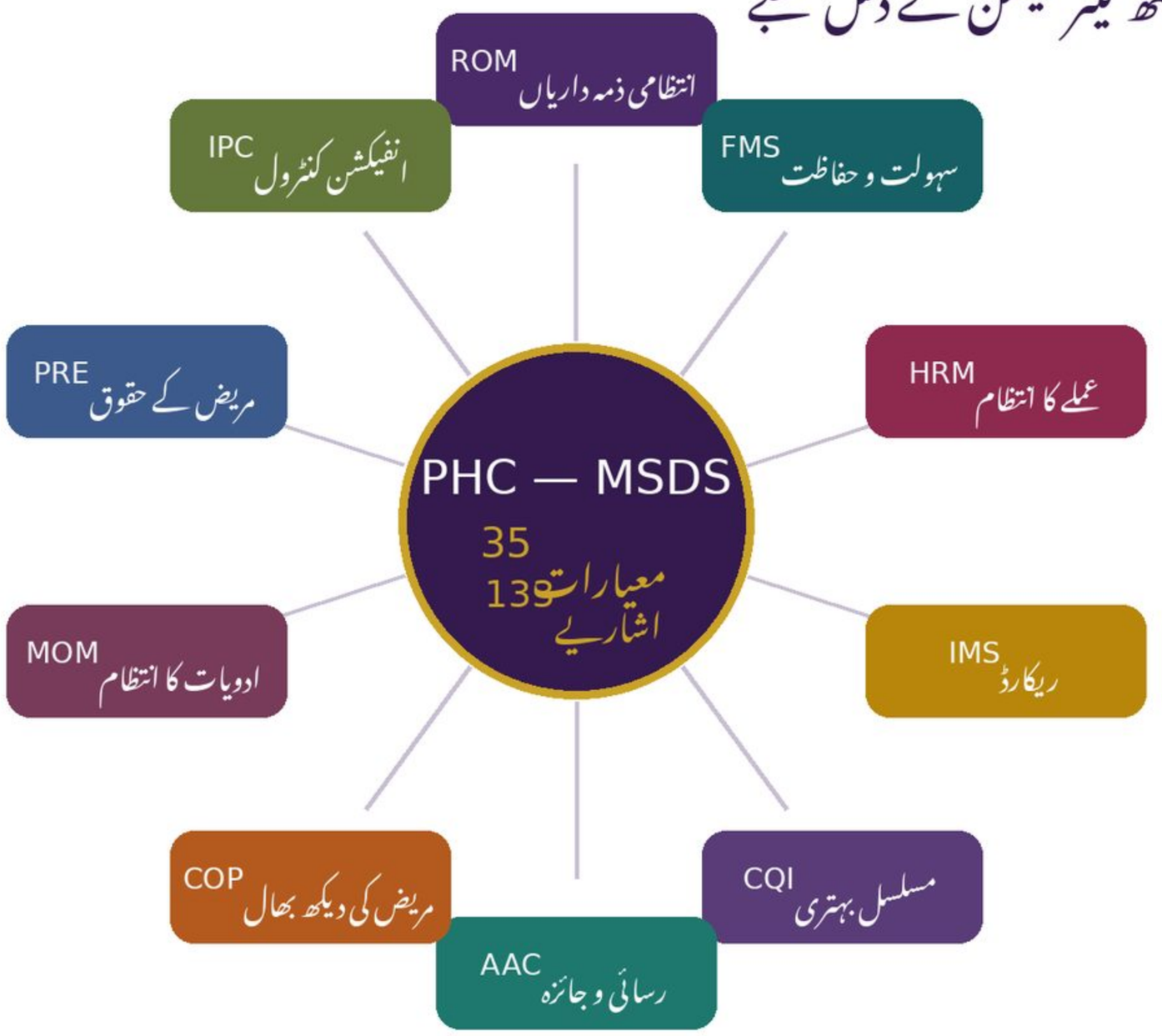
Punjab Healthcare Commission and the MSDS Standards

پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن اور MSDS معیارات



پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن (PHC) صوبائی حکومت کا ادارہ ہے جو نجی طبی اداروں کو لائسنس دیتا ہے اور ان کے معیارِ خدمات کی جانچ کرتا ہے۔ نفسیاتی اور نشے کے علاج و بحالی کے اداروں کے لیے PHC نے کم از کم معیاراتِ خدمات (MSDS — Minimum Service Delivery Standards، دستاویز نمبر CG-19MS-ED1-270522) جاری کیے ہیں، جن میں 35 معیارات اور 133 اشاریے ہیں۔ ندا کلینک انھی معیارات پر اپنا اندرونی نظام قائم رکھتا اور برقرار رکھتا ہے۔

پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے دس شعبے



PHC MSDS کے دس شعبے — 35 معیارات، 133 اشاریے

35 Standards Across Ten Areas

دس شعبوں کے 35 معیارات

شعبہ	معیارات	بنیادی تقاضا
ROM — انتظامی ذمہ داریاں	معیار 1 تا 5	قانونی حیثیت اور PHC لائسنس، عملے کی شناخت، مناسب عمارت، واضح مشن و پالیسیاں، قوانین کی پابندی
FMS — سہولت و حفاظت	معیار 6 تا 9	عمارت کا مناسب نقشہ، مریضوں و کھانے و ادویات کی حفاظت، آگ و ہنگامی منصوبے، آلات کا نظام
HRM — عملے کا انتظام	معیار 10 تا 14	اہلیت کے معیارات، بھرتی و تربیتی تقاریر (orientation)، کارکردگی کا جائزہ، اسناد کی تصدیق
IMS — معلومات و ریکارڈ	معیار 15 تا 16	ہر مریض کا مکمل، منفرد شناختی ریکارڈ اور اس کا باقاعدہ جائزہ
CQI — مسلسل بہتری	معیار 17 تا 19	معیار بہتر بنانے کا منصوبہ، نگرانی اور سنگین واقعات (sentinel events) کا تجزیہ

AAC — رسائی و جائزہ	معیار 20 تا 22	درج شدہ خدمات ہی فراہم کرنا، منظم داخلہ و جائزہ (معیاری تشخیصی اوزار / DSM-5، ICD-11 تشخیصی سہولتیں)
COP — مریض کی دیکھ بھال	معیار 23 تا 27	ایمرجنسی پالیسیاں، داخلہ و رہائی کے ضوابط، تشخیص پر مبنی علاجی منصوبہ، بدسلوکی کی روک تھام
MOM — ادویات کا انتظام	معیار 28 تا 29	نسخہ لکھنے کے اصول، ادویات کی محفوظ ذخیرہ و تقسیم
PRE — مریض کے حقوق	معیار 30 تا 34	جامع ذہنی دیکھ بھال کا حق، باخبر رضامندی، لاگت کی معلومات، شکایت کا حق، رازداری
IPC — انفیکشن کنٹرول	معیار 35	تحریری انفیکشن کنٹرول پروگرام، حفاظتی طریقے اور عملے کی تربیت

What These Standards Mean for You

یہ معیارات آپ کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟

جب آپ کسی PHC رجسٹرڈ ادارے میں جاتے ہیں تو یہ معیارات ضمانت ہیں کہ وہاں قانونی حیثیت، اہل عملہ، رازداری، حفاظت اور شکایت سننے کا نظام موجود ہے۔ ادارہ منتخب کرتے وقت PHC لائسنس ضرور پوچھیں۔

باب 20

How PHC Standards Are Applied at Nida Clinic

ندا کلینک میں PHC معیارات کا اطلاق



MSDS کے 133 اشاریوں میں سے وہ کلیدی اشاریے جو ندا کلینک میں روزمرہ عمل کی شکل اختیار کرتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے:

اشاریہ	تقاضا	ندا کلینک میں عملی صورت
Ind-01 و 02	نام اور PHC لائسنس نمبر کی نمائش، رجسٹریشن	داخلی و خارجی بورڈز پر نام و لائسنس نمبر نمایاں؛ لائسنس کی تجدید بروقت
Ind-04 و 05	عملے کے شناختی کارڈ اور نام و اہلیت کی نمائش	ہر ملازم کا بیج؛ دفاتر پر نام، اہلیت اور عہدہ
Ind-08	معائنہ و کاؤنسلنگ کے دوران پرائیویسی	الگ کاؤنسلنگ کمرے؛ ایک وقت میں ایک مریض
Ind-11	تحریری مشن بیان	مشن بیان تحریری، نمایاں اور عملے کو معلوم
Ind-17 و 18	ایمرجنسی اور سیکیورٹی SOPs	تحریری ہنگامی طریقۂ کار اور تربیت یافتہ عملہ
Ind-36 و 37	سالانہ ہنگامی مشق اور عملے کی تربیت	سالانہ mock drill اور ریکارڈ

Ind-40 تا 43	اہلیت کے معیارات اور مناسب عملہ	کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹ کی نگرانی؛ PMDC/PNC اہلیت کی تصدیق
Ind-55 تا 58	مکمل اور منفرد طبی ریکارڈ	ہر مریض کا الگ فائل نمبر، تاریخ و دستخط کے اندراجات
Ind-66	CQI کمیٹی اور منصوبہ	معیار بہتری کمیٹی کے اجلاس اور ریکارڈ
Ind-74 و 75	سینٹینل واقعات کی تعریف اور تجزیہ	واقعاتی رپورٹنگ اور اصلاحی اقدامات
Ind-80 تا 82	معیاری اوزار سے تشخیص، نشے کے مریض میں ذہنی جائزہ	DSM-5 / ICD-11 پر مبنی تشخیص؛ ہر مریض کی نفسیاتی جانچ
Ind-94	ضرورت پر اعصابی (neurological) جائزہ	جسمانی و اعصابی معائنہ معیاری عمل کا حصہ
Ind-109 تا 112	ادویات کے نسخے اور محفوظ انتظام	صرف اہل ڈاکٹر کے نسخے؛ کنٹرول ادویات کی محفوظ الگ ذخیرہ گاہ
Ind-116	مریض و خاندان کی تعلیم	تعلیمی سیشن اور یہ کتابچہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے
Ind-123 تا 125	شکایت کا حق اور منصفانہ ازالہ	شکایت باکس و رجسٹر، ذمہ دار افسر، نتائج سے بہتری
Ind-127 و 128	شناخت اور مرض کی رازداری	تصویر و میڈیا پابندی؛ ریکارڈ کی محفوظ دسترس
Ind-129 تا 133	انفیکشن کنٹرول پروگرام	تحریری پلان، حفاظتی تدابیر اور عملے کی تربیت

Rights of Patients and Families (PRE Standards)

مریض اور خاندان کے حقوق (PRE معیارات)

- عزت اور عدم امتیاز کے ساتھ علاج کا حق۔
- علاج، متبادل اور لاگت کے بارے میں مکمل معلومات اور باخبر رضامندی کا حق۔
- رازداری کا حق: آپ کی شناخت، مرض اور تصاویر کسی پر ظاہر نہ ہوں۔
- شکایت کرنے اور اس کے منصفانہ و بروقت ازالے کا حق۔
- کسی بھی قسم کی بدسلوکی سے تحفظ کا حق۔

Our Promise

ہمارا وعدہ

یہ حقوق کاغذی نہیں — ندا کلینک میں ان کے تحفظ کی ذمہ داری مخصوص افسران کو سونپی گئی ہے اور CQI نظام میں ان کا باقاعدہ جائزہ ہوتا ہے۔ کوئی خلاف ورزی نظر آئے تو 0321-7507866 پر اطلاع دیں۔

باب 21

Trusted International Resources (Online)

قابلِ اعتماد بین الاقوامی وسائل (انٹرنیٹ)



ذیل کے ادارے نشے اور ذہنی صحت پر دنیا کے معتبر ترین مفت ذرائع ہیں۔ ان کی ویب سائٹس انگریزی میں ہیں؛ پیشہ ور افراد اور انگریزی پڑھنے والے خاندانی افراد کے لیے نہایت مفید ہیں۔

ادارہ	ویب سائٹ	کیا ملتا ہے
SAMHSA (امریکہ)	samhsa.gov	نشے اور ذہنی صحت کی علاج کی تلاش (findtreatment.gov)، قومی ہیلپ لائن 1-800-662-4357، خاندانوں کے لیے رہنمائیاں
NIDA (امریکہ)	nida.nih.gov	منشیات اور لت پر تحقیقی معلومات؛ Principles of Drug Addiction Treatment — علاج کے ثابت شدہ اصول
Hazelden Betty Ford (امریکہ)	hazeldenbettyford.org	منی سوٹا ماڈل کا عالمی مرکز؛ خاندانوں اور پیشہ ور کے لیے کتب و وسائل
Alcoholics Anonymous	aa.org	بارہ اقدامات کا اصل متن اور دنیا بھر کی میٹنگز

Narcotics Anonymous	na.org	منشیات کے عادی افراد کے لیے بارہ اقداماتی پروگرام اور میٹنگز
SMART Recovery	smartrecovery.org	سائنس پر مبنی سیلف ہیلپ — بارہ اقدامات کا متبادل راستہ
Al-Anon Family Groups	al-anon.org	عادی مریض کے خاندان کے لیے سپورٹ گروپ
NAMI (امریکہ)	nami.org	ذہنی امراض کی تعلیم اور خاندانی سپورٹ
mhGAP — WHO	who.int	عالمی ادارۂ صحت کی ذہنی صحت اور نشے کے علاج کی رہنما ہدایات
UNODC	unodc.org	منشیات کے عالمی و پاکستانی سروے اور تحقیق
EUDA (یورپ)	euda.europa.eu	یورپی منشیات کی صورتحال اور تحقیق

A Word of Care

خیال

انٹرنیٹ کی معلومات عمومی ہوتی ہیں؛ اپنی ذاتی صورتحال کے فیصلے ہمیشہ اپنے ماہر کے ساتھ کریں۔ سوشل میڈیا کے تجرباتی نسخے اور بازار کی غیر معیاری ادویات سے بچیں — نقلی منشیات زہریلی ہو سکتی ہیں۔

الف

Frequently Asked Questions (for Families)

اکثر پوچھے گئے سوالات (خاندانوں کے لیے)



Is addiction really treatable?

کیا لت کا علاج واقعی ممکن ہے؟

جی ہاں۔ لت دائمی بیماری ہے مگر اس پر قابو پانا اور مکمل زندگی گزارنا ممکن ہے — بالکل شوگر اور بلڈ پریشر کی طرح۔ لاکھوں افراد، جن میں ہمارے سینکڑوں سابق مریض شامل ہیں، برسوں سے پاکیزہ اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔

How long does treatment take?

علاج میں کتنا وقت لگتا ہے؟

ڈی ٹاکس عموماً چند روز سے دو ہفتے؛ رہائشی بحالی عموماً چار سے بارہ ہفتے؛ اور بعد از علاج نگہداشت مہینوں تک جاری رہتی ہے۔ تحقیق کے مطابق کم از کم تین ماہ کا مسلسل علاج ہی پائیدار نتائج دیتا ہے۔

Does the patient have to be willing?

کیا مریض کو رضاکار ہونا ضروری ہے؟

بہتر نتائج رضاکارانہ علاج سے ملتے ہیں، مگر تجربہ یہ بھی ہے کہ خاندانی محبت اور ماہر کی رہنمائی سے شروع میں ہچکچانے والے

مریض علاج کے دوران خود شریک ہو جاتے ہیں۔ قانونی تقاضوں (مثلاً مریض کو گھر سے لانے کے طریقے) پر PHC کے ضوابط کی پابندی کرتے ہیں۔

Will anyone find out about the treatment?

کیا علاج کی خبر کسی کو ہوگی؟

نہیں۔ آپ کی شناخت اور علاج مکمل راز ہے — یہ PHC کے معیار PRE-5 کی ضمانت اور ہماری اہلیتی ذمہ داری ہے۔

What facilities are there for women?

خواتین کے لیے کیا سہولت ہے؟

خواتین کی لت اکثر چھپی ہوتی ہے اور شرم کی وجہ سے علاج دیر سے ملتا ہے۔ ندا کلینک میں خواتین کے لیے پرائیویسی کا مکمل انتظام اور خصوصی توجہ موجود ہے؛ خواتین مریضوں کا جائزہ ان کی مخصوص ضروریات سمیت ہوتا ہے۔

How much does treatment cost?

علاج کی لاگت کتنی ہوگی؟

لاگت علاج کی قسم اور دورانیے پر منحصر ہے؛ داخلہ سے پہلے مکمل تحریری تفصیل دی جاتی ہے (PHC معیار PRE-3)۔ نیاپن کی بنیاد پر رعایت کے اصول بھی موجود ہیں — ہمارا مشن خدمت ہے، نہ صرف کاروبار۔

Are the Twelve Steps tied to a particular religion?

کیا بارہ اقدامات کسی خاص مذہب سے جڑے ہیں؟

نہیں۔ بارہ اقدامات بلند قوت — جیسے ہر شخص اسے سمجھے کے اصول پر ہیں اور ہر عقیدے کے انسان کے لیے کھلے ہیں۔ یہ خود احتسابی، تلافی اور خدمت کا عملی پروگرام ہے۔

What if a relapse happens?

واپسی (relapse) ہو جائے تو کیا کریں؟

گھبرائیں نہیں اور الزام نہ دیں۔ فوراً کلینک سے رابطہ کریں؛ واپسی بیماری کا ممکنہ حصہ ہے اور بروقت دخل سے جلد قابو آتی ہے۔ ناکامی نہیں — علاج جاری رکھنا ہی کامیابی ہے۔

ب

Glossary of Key Terms

کلیدی اصطلاحات کی فرہنگ

اصطلاح	آسان اردو مفہوم
Addiction / لت	کسی شے یا عمل کے باوجود نقصانات کے بار بار استعمال کی بیماری
Tolerance / برداشت	پہلے والے اثر کے لیے بڑی مقدار کی ضرورت
Dependence / انحصار	جسم یا ذہن کا نشے کے بغیر نارمل نہ رہنا
Withdrawal / وٹھ ڈرال	نشہ چھوڑنے پر آنے والی علامات
Detox / ڈی ٹاکس	طبی نگرانی میں جسم سے نشے کی پاکی
Craving / خواہش	نشے کی شدید و ناقابلِ برداشت تمنا
Relapse / واپسی	پرہیز کے بعد دوبارہ استعمال
Trigger / محرک	وہ صورتحال، جگہ یا جذبہ جو خواہش جگائے
Dual Diagnosis / دوہرا مرض	لت اور ذہنی مرض کا ساتھ ہونا
MAT	ادویات معاونتِ علاج (مثلاً بوپرینورفین) — ڈاکٹر کی نگرانی میں
Psychotherapy / نفسیاتی علاج	باتوں اور مہارتوں کے ذریعے علاج (CBT وغیرہ)
Aftercare	علاج کے بعد کی مسلسل نگہداشت
Enabling / مہمیز کرنا	ایسا تعاون جو نشے کو آگے بڑھائے
PHC	پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن — نجی طبی اداروں کا نگران ادارہ
MSDS	کم از کم معیاراتِ خدمات — PHC کے 35 معیارات و 133 اشاریے
DSM-5 / ICD-11	ذہنی امراض کی عالمی تشخیصی درجہ بندی کے معیار
PWID	انجیکشن سے نشہ استعمال کرنے والے افراد

ج
References

حوالہ جات

- Punjab Healthcare Commission: MSDS and Reference Manual for Psychiatric and Addiction Treatment / Rehabilitation Facilities (CG-19MS-ED1-270522))۔
- UNODC / Ministry of Narcotics Control / Pakistan Bureau of Statistics: Drug Use in Pakistan—National Survey 2013))؛ نئی قومی سروے 2022-24 جاری ہے۔ unodc.org
- SAMHSA: National Survey on Drug Use and Health 2024؛ National Helpline؛ samhsa.gov—findtreatment.gov
- NIDA: Principles of Drug Addiction Treatment—A Research-Based Guide (Third Edition)—nida.nih.gov
- Hazelden Betty Ford Foundation: The Minnesota Model—hazeldenbettyford.org
- Narcotics Anonymous—aa.org; Alcoholics Anonymous: The Twelve Steps—na.org
- European Union Drugs Agency (EUDA): European Drug Report 2025—euda.europa.eu
- WHO: mhGAP Intervention Guide—who.int
- پنجاب ذہنی صحت (ترمیمی) ایکٹ 2014 اور Mental Health Ordinance 2001 (رازداری و مریض کے حقوق کے دفعات)۔

اختتام
A Final Word

آخری بات



اگر یہ کتابچہ آپ تک پہنچا ہے تو ممکن ہے آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس بیماری سے لڑ رہا ہو۔ جان لیجیے: آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ پر کوئی لعنت نہیں، اور راستہ موجود ہے۔ پہلا قدم صرف ایک فون کال کی دوری پر ہے۔

ندا کلینک 1999 سے اسی یقین کے ساتھ کھڑا ہے: ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں؛ ان کی ذہنی صحت اور خوشی ہمارا مشن ہے۔

Contact Us

رابطہ کریں

ندا کلینک — ڈاکٹر بلال وڑائچ اور ہماری ماہرین کی ٹیم (ڈاکٹرز، کنسلٹنٹ سائیکاٹرسٹس اور کلینیکل سائیکالوجسٹس)۔ پتہ 99 : ویسٹ ووڈ کالونی، لاہور، پاکستان۔ موبائل / واٹس ایپ: 0321-7507866۔ ویب سائٹ: nidaclinic.com۔

Disclaimer

ڈسکلیمر

یہ کتابچہ عمومی تعلیم کے لیے ہے اور کسی فرد کے لیے طبی مشورہ، تشخیص یا نسخہ نہیں۔ کوئی بھی علاج یا دوا صرف اہل طبی ماہر کے مشورے سے کریں۔ ایمرجنسی میں قریبی ہسپتال جائیں یا فوراً کلینک سے رابطہ کریں۔